Estilo UERJ

Simulado 6
Resolução

Gabarito, a armadilha de cada questão, o dado que decide e o raciocínio completo, alternativa por alternativa.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE CORRIGIR

Como usar esta resolução

Corrija olhando primeiro a coluna da arma. O que interessa não é o total de acertos, é em qual armadilha você caiu.

ARMA DA BANCA	O QUE FAZ	QUESTÕES	ONDE ESTÃO
Rótulo verdadeiro	um dado real do paciente puxa para a doença de manual errada	14	4, 6, 8, 10, 25, 31, 34, 37, 40, 42, 46, 48, 49, 50
Negativo no meio	o discriminante é um dado negativo no meio do caso	5	5, 15, 19, 36, 41
Dado omitido	o achado mais famoso foi retirado	3	16, 22, 38
Droga a deduzir	a droga em uso não é nomeada	4	9, 11, 14, 47
Grade X / Y	alternativa composta em que uma metade não basta	7	1, 24, 26, 28, 29, 33, 43
Qualificador	o comando restringe o que se pede	3	13, 17, 35
Limiar	um ponto de corte ou janela decide	7	7, 12, 18, 20, 21, 39, 44
Omissão	a resposta certa é não fazer, ou o degrau mais simples	3	2, 23, 32
Cronologia	o tempo entre os eventos decide	4	3, 27, 30, 45

O que cada arma treina em você

- **Rótulo verdadeiro, negativo no meio, dado omitido:** a leitura em modo confirmação, a sua maior causa de erro de identificação.
- **Grade X / Y e qualificador:** a alternativa aceita pela metade e o comando lido pela metade.
- **Limiar, cronologia e omissão:** a regra aplicada sem checar a condição que a habilita, e o exame ou tratamento a mais, o seu padrão dominante em 15/10/2026.
- **Droga a deduzir:** a droga em uso que decide e não vem nomeada.

Todas as questões têm uma única alternativa defensável pela diretriz citada. Se discordar de alguma, anote: discutir o gabarito é o melhor treino.

GABARITO

Respostas

1 **A**	2 **D**	3 **A**	4 **B**	5 **B**	6 **D**	7 **D**	8 **B**	9 **B**	10 **A**
11 **B**	12 **D**	13 **D**	14 **C**	15 **B**	16 **A**	17 **A**	18 **A**	19 **D**	20 **C**
21 **B**	22 **A**	23 **C**	24 **B**	25 **D**	26 **B**	27 **C**	28 **A**	29 **A**	30 **A**
31 **C**	32 **B**	33 **C**	34 **D**	35 **C**	36 **C**	37 **A**	38 **B**	39 **C**	40 **A**
41 **C**	42 **B**	43 **A**	44 **C**	45 **D**	46 **D**	47 **D**	48 **C**	49 **B**	50 **D**

A cor ao lado de cada letra é a da arma da banca, como na tabela anterior. Distribuição: A 13, B 13, C 12, D 12.

RESOLUÇÃO

Questão por questão

1

Cardiologia · Hipercolesterolemia familiar com hipotireoidismo subclínico: estatina de alta potência já e rastreio em cascata

Grade X / Y

Gabarito A

Homem de 34 anos, assintomático, procura o ambulatório após exame admissional. O pai teve infarto aos 46 anos e um tio paterno morreu subitamente aos 50. Não fuma, IMC 24 kg/m², PA 122×76 mmHg. Exame: espessamento nodular dos tendões de Aquiles e dos extensores dos dedos das mãos e arco corneano incompleto. Exames em jejum, repetidos: colesterol total 352 mg/dL, LDL-c 271 mg/dL, HDL-c 48 mg/dL, triglicerídeos 110 mg/dL, glicemia 88 mg/dL; TSH 8,9 mUI/L (VR 0,4 a 4,5), T4 livre 1,0 ng/dL (VR 0,7 a 1,8), anti-TPO positivo em título alto; creatinina, enzimas hepáticas, albumina e urina normais. Além de orientar dieta, a conduta para o paciente e a conduta para a família são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

espessamento nodular dos tendões de Aquiles e dos extensores dos dedos das mãos

Resolução. O TSH de 8,9 com anti-TPO positivo é um rótulo verdadeiro (há tireoidite de Hashimoto): hipotireoidismo eleva o LDL e deve ser excluído como causa secundária, e quem lê só isso trata a tireoide e espera. Mas hipotireoidismo subclínico com TSH abaixo de 10 e T4 livre normal eleva o LDL em poucos mg/dL e não explica LDL de 271 mg/dL, muito menos xantomas tendíneos, que são marca da hipercolesterolemia familiar. Pelo escore da Dutch Lipid Clinic Network, LDL entre 250 e 329 mg/dL (5 pontos), xantoma tendíneo (6), arco corneano antes dos 45 anos (4) e parente de primeiro grau com doença coronária precoce (1) somam 16, diagnóstico definido (acima de 8). A conduta é estatina de alta potência desde já (rosuvastatina 20 a 40 mg ou atorvastatina 40 a 80 mg), visando reduzir o LDL em pelo menos 50%, com ezetimiba se necessário. A segunda metade é a que se esquece: a doença é autossômica dominante, metade dos parentes de primeiro grau a herda, e o rastreio em cascata (perfil lipídico e, se disponível, genético) é recomendado.

A) Estatina de alta potência / rastrear parentes de 1º grau CORRETA

Correta. LDL de 271 com xantomas tendíneos e história familiar é hipercolesterolemia familiar definida: estatina de alta potência e rastreio em cascata dos parentes de primeiro grau.

B) Estatina de alta potência / sem rastreio familiar

Errada. Acerta o tratamento, mas a hipercolesterolemia familiar é autossômica dominante e o rastreio em cascata é parte obrigatória da conduta.

C) Levotiroxina e repetir lipídios / rastrear parentes

Errada. Erra a primeira metade: TSH de 8,9 com T4 livre normal não explica LDL de 271 nem xantomas; a levotiroxina pode ser discutida pelo anti-TPO positivo, mas não substitui nem adia a estatina.

D) Levotiroxina e repetir lipídios / sem rastreio familiar ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Atribui tudo ao hipotireoidismo subclínico, que seria a causa a corrigir com LDL discretamente elevado, sem xantomas e com TSH acima de 10.

Para levar. LDL de 190 mg/dL ou mais, com xantoma tendíneo ou história familiar precoce, é hipercolesterolemia familiar até prova em contrário: estatina de alta potência e rastreio em cascata; hipotireoidismo subclínico não explica LDL dessa ordem.

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (SBC 2017) e I Diretriz Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar (SBC 2012); ESC/EAS 2019 (dyslipidaemias)

2

Alergia · Urticária crônica espontânea sem controle com anti-histamínico em dose padrão: quadruplicar a dose antes do omalizumabe

Omissão **Gabarito D**

Mulher de 34 anos tem há 10 semanas placas eritematoedematosas pruriginosas quase diárias, cada uma durando menos de 24 horas e desaparecendo sem deixar marca, com episódios ocasionais de edema palpebral. Sem febre, artralgia, perda de peso ou dor óssea. Não identifica desencadeante e nega uso de anti-inflamatórios. Usa loratadina 10 mg/dia há 6 semanas, com melhora parcial e escore de atividade semanal (UAS7) de 24. Traz hemograma, VHS, PCR e TSH normais. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Usa loratadina 10 mg/dia há 6 semanas

Resolução. O UAS7 de 24 indica doença ativa e o omalizumabe é eficaz, o que faz parecer que a hora do biológico chegou. Mas ele é o terceiro degrau: as diretrizes exigem antes a falha do anti-histamínico H1 de segunda geração em até quatro vezes a dose padrão, por 2 a 4 semanas, e a paciente só usou a dose simples. A investigação extensa (FAN, anticorpos tireoidianos, parasitológico, alérgenos) não é recomendada quando hemograma, provas inflamatórias e história não sugerem outra causa, e não muda a conduta. Corticoide contínuo é proscrito na urticária crônica; no máximo um curso de até 10 dias numa exacerbação. O degrau certo é o mais simples: quadruplicar a loratadina e reavaliar.

A) Prednisona contínua em dose baixa
Errada. Corticoide só em curso curto de até 10 dias numa exacerbação grave; o uso contínuo é proscrito pelos efeitos adversos.

B) Iniciar omalizumabe subcutâneo ARMADILHA
Errada. Seria o passo após falha do anti-H1 em até quatro vezes a dose; a paciente ainda está na dose padrão.

C) Pesquisar FAN, anti-TPO e parasitas
Errada. Com hemograma, VHS, PCR e TSH normais e sem sinais sistêmicos, a bateria não é recomendada e não muda a conduta.

D) Aumentar a loratadina até 40 mg/dia CORRETA
Correta. A dose padrão por 6 semanas não controlou; o próximo degrau é até quatro vezes a dose do anti-H1 de segunda geração.

Para levar. Urticária crônica espontânea: anti-H1 de segunda geração em dose padrão, depois até quatro vezes a dose, e só então omalizumabe; corticoide contínuo e bateria de exames não entram.

EAACI/GA²LEN/EuroGuiDerm/APAAACI guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria (2021).

---

3 Pneumologia · Hemoptise maciça com lado definido: decúbito sobre o pulmão que sangra antes de qualquer exame

Cronologia **Gabarito A**

Homem de 52 anos, com sequela de tuberculose tratada há 10 anos (cavidade residual no lobo superior direito), chega à emergência após expectorar cerca de 400 mL de sangue vivo nas últimas 3 horas. Está acordado e ansioso, fala frases curtas e tem nova golfada de sangue durante o exame. PA 128 × 80 mmHg, FC 112 bpm, SpO2 89% em ar ambiente, estertores grossos em todo o hemitórax direito, com o esquerdo limpo. Não usa anticoagulante; plaquetas e coagulograma normais. A equipe de radiologia intervencionista chega em 40 minutos. Enquanto se oferece oxigênio e se obtém acesso venoso, a primeira medida é:

O DADO QUE DECIDE

estertores grossos em todo o hemitórax direito, com o esquerdo limpo

Resolução. Na hemoptise maciça o paciente morre por asfixia, e não por choque: o sangue inunda o pulmão que ainda troca gás. Por isso a ordem é proteger o pulmão bom antes de localizar ou tratar a fonte. O lado já está definido pela cavidade residual à direita e pelos estertores só à direita, então a primeira medida é deitá-lo em decúbito lateral sobre o lado direito, para que o sangue não escorra para o esquerdo; se a via aérea se perder, intubação com tubo calibroso (ou seletiva do brônquio esquerdo). A angiotomografia é o exame certo para planejar a embolização, mas vem depois, com via aérea protegida; a broncoscopia rígida ou flexível também é passo seguinte, não o primeiro. Ácido tranexâmico é adjuvante e não substitui a proteção da via aérea.

A) Decúbito lateral sobre o lado direito CORRETA

Correta. Lado sangrante definido: decúbito sobre ele, protegendo o pulmão esquerdo limpo, é a primeira medida.

B) Broncoscopia flexível à beira do leito

Errada. Broncoscopia localiza e controla temporariamente, mas vem depois de posicionar e garantir a via aérea; seria o primeiro passo com o lado desconhecido e via aérea já protegida.

C) Angiotomografia de tórax imediata ARMADILHA

Errada. É o exame que antecede a embolização no paciente estabilizado; feito agora, leva ao tomógrafo um paciente que pode afogar no caminho.

D) Ácido tranexâmico e observação

Errada. Antifibrinolítico é adjuvante, útil na hemoptise não maciça; aqui a ameaça é a via aérea.

Para levar. Hemoptise maciça: primeiro proteger o pulmão bom (decúbito sobre o lado que sangra, intubação se preciso), depois localizar (angiotomografia, broncoscopia) e por fim embolizar a artéria brônquica.

Davidson K, Shojaee S. Managing massive hemoptysis. Chest 2020; Ittrich H et al. The diagnosis and treatment of hemoptysis. Dtsch Arztebl Int 2017.

4 Infectologia · Acidente laquético: síndrome vagal separa da jararaca quando o quadro local é igual

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 41 anos, trabalhador de fazenda de cacau no sul da Bahia, em área de mata, chega ao PS 2 horas após ser picado na perna direita por serpente que não conseguiu ver bem. Refere dor intensa no local. Exame: edema do pé até o joelho, equimose e duas bolhas próximas à picada; sem ptose, sem diplopia, sem fácies miastênica. Há 40 minutos tem cólicas abdominais, três episódios de diarreia e vômitos, com sudorese profusa. FC 46 bpm, PA 84 × 50 mmHg, FR 20 irpm. Tempo de coagulação: incoagulável. CK 310 U/L, urina de cor normal. O gênero da serpente mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

FC 46 bpm, PA 84 × 50 mmHg

Resolução. Dor intensa, edema extenso, equimose, bolhas e sangue incoagulável são verdadeiros e apontam para a jararaca, que responde pela grande maioria dos acidentes ofídicos no Brasil. Mas a ação proteolítica, coagulante e hemorrágica é comum ao Bothrops e ao Lachesis; o que separa os dois é a síndrome vagal do laquético: bradicardia, hipotensão, cólica, diarreia, vômitos e sudorese, que aqui surgiram cedo. Hipotensão no botrópico grave vem por sangramento ou perda para o terceiro espaço e acompanha taquicardia, não bradicardia. A epidemiologia (mata atlântica do sul da Bahia, área da surucucu) reforça. O crotálico dá pouco quadro local, fácies miastênica e mialgia com CK alta e urina escura; o elapídico é neuroparalítico puro. O tratamento é o soro antibotrópico-laquético; o antibotrópico isolado não neutraliza o veneno laquético.

A) Crotalus

Errada. O crotálico tem pouco edema local e cursa com fácies miastênica, mialgia, CK muito alta e urina escura, ausentes aqui.

B) Lachesis CORRETA

Correta. Quadro local proteolítico com incoagulabilidade mais síndrome vagal (bradicardia, hipotensão, diarreia, cólica) em área de mata define o laquético, tratado com soro antibotrópico-laquético.

C) Micrurus

Errada. O elapídico não causa edema, bolhas nem coagulopatia: é ptose, diplopia e paralisia descendente.

D) Bothrops ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o botrópico explicaria todo o quadro local e a incoagulabilidade, mas não a bradicardia com hipotensão e diarreia.

Para levar. Quadro de jararaca com bradicardia, hipotensão, cólica e diarreia é surucucu (Lachesis): o soro é o antibotrópico-laquético.

Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde, 6ª ed. (2023), acidentes por animais peçonhentos; Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos (MS/Funasa, 2001).

5 Endocrinologia · Pé de Charcot agudo com radiografia normal: descarga imediata, e não antibiótico para celulite

Negativo no meio **Gabarito B**

Homem de 61 anos, com diabetes tipo 2 há 20 anos (HbA1c 8,4%) e neuropatia periférica (monofilamento não percebido em ambos os pés), procura atendimento porque há 10 dias o pé direito ficou inchado, quente e vermelho após uma torção leve ao descer da calçada. Refere apenas desconforto discreto e continua andando normalmente. Nega febre. Exame: pé direito edemaciado e eritematoso no mediopé, temperatura cutânea 3,2 °C maior que a do pé esquerdo, pele íntegra, sem úlcera ou porta de entrada entre os dedos, pulsos pediosos amplos; o eritema desaparece após elevação do membro por 5 minutos. Leucócitos 7.800/mm³, PCR 6 mg/L (VR até 5). Radiografia do pé com carga: sem fratura, sem erosão ou luxação. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

o eritema desaparece após elevação do membro por 5 minutos

Resolução. Pé quente, vermelho e inchado em diabético atrai antibiótico para celulite. Os negativos do meio derrubam a infecção: pele íntegra sem porta de entrada, sem febre, leucócitos normais, PCR quase normal e, sobretudo, eritema que some com a elevação do membro (na celulite ele persiste). Neuropatia grave, trauma mínimo, dor desproporcionalmente pequena e diferença de temperatura acima de 2 °C entre os pés compõem a neuroartropatia de Charcot ativa. A radiografia normal não afasta: na fase inicial (estágio 0) as alterações só aparecem na ressonância. O tratamento não espera a imagem, porque cada dia de carga sobre o pé ativo pode colapsar o mediopé: imobilização com gesso de contato total (ou órtese de joelho a tornozelo não removível) e retirada da carga, mantidos até a temperatura se igualar, com ressonância para confirmar e estadiar, pedida sem adiar a imobilização.

A) Ressonância do pé antes de imobilizar
Errada. A ressonância confirma e estadia o Charcot de radiografia normal (estágio 0), mas a descarga não espera por ela; seria a resposta se a pergunta fosse o exame para confirmar.

B) Gesso de contato total CORRETA
Correta. Charcot ativo suspeito (neuropatia, pé quente com diferença acima de 2 °C, sem infecção) exige descarga imediata com gesso de contato total, mesmo com radiografia normal.

C) Biópsia óssea antes de tratar
Errada. Biópsia óssea é para osteomielite suspeita, em geral sob úlcera; sem ferida nem marcadores inflamatórios, é procedimento a mais e atrasa a descarga.

D) Antibiótico oral para celulite ARMADILHA
Errada. É a armadilha: celulite teria porta de entrada, febre ou leucocitose, e o eritema não sumiria com a elevação do membro.

Para levar. Diabético com neuropatia e pé quente, vermelho e inchado sem ferida é Charcot até prova em contrário: descarga imediata com gesso de contato total, sem esperar a radiografia mudar.

IWGDF 2023 (Guidelines on the diagnosis and treatment of active Charcot neuro-osteoarthropathy in persons with diabetes mellitus); Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (capítulo de pé diabético).

6 Hematologia · Policitemia vera de baixo risco com plaquetose e fatores de risco cardiovascular: flebotomia com alvo de 45% e AAS, sem citorredução

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 54 anos, hipertenso e dislipidêmico, em uso de losartana e atorvastatina, ex-tabagista há 10 anos, é encaminhado por hematócrito alto em exame de rotina. Refere cefaleia leve e prurido após o banho há 1 ano. Nunca teve trombose, AVC ou infarto. Exame: PA 128 × 80 mmHg, pletora facial, baço palpável a 2 cm do rebordo costal. Hemograma: Hb 18,9 g/dL, hematócrito 57%, leucócitos 11.200/mm³, plaquetas 640.000/mm³. SpO2 97% em ar ambiente, eritropoetina sérica baixa e mutação JAK2 V617F positiva. O colega que o encaminhou sugere iniciar hidroxiureia por causa das plaquetas e do risco cardiovascular. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Nunca teve trombose, AVC ou infarto

Resolução. O diagnóstico de policitemia vera está fechado (hematócrito acima de 49%, JAK2 V617F positivo, eritropoetina baixa), e a pergunta é o porte do tratamento. A plaquetose de 640.000, a hipertensão, a dislipidemia e o tabagismo prévio são verdadeiros e puxam para a citorredução, mas a estratificação de risco trombótico da policitemia vera usa só dois critérios: idade de 60 anos ou mais e trombose prévia. Com 54 anos e sem trombose, ele é de baixo risco, e o tratamento é flebotomia com alvo de hematócrito abaixo de 45% (o estudo CYTO-PV mostrou mais eventos cardiovasculares com alvo entre 45% e 50%) associada a AAS em dose baixa. Os fatores de risco cardiovascular se tratam com as drogas deles, não com hidroxiureia. Plaquetas abaixo de 1 milhão a 1,5 milhão, leucócitos abaixo de 15.000 e esplenomegalia discreta não indicam citorredução no baixo risco.

A) Ruxolitinibe, flebotomias e AAS
Errada. O ruxolitinibe é segunda linha, para resistência ou intolerância à hidroxiureia ou prurido refratário, e não tratamento inicial do baixo risco.

B) Flebotomias (hematócrito abaixo de 50%) e AAS
Errada. O alvo de 50% é o antigo; no CYTO-PV, manter o hematócrito entre 45% e 50% aumentou morte cardiovascular e trombose maior.

C) Hidroxiureia, flebotomias e AAS ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria a conduta no alto risco (60 anos ou mais, ou trombose prévia) ou com plaquetas acima de 1,5 milhão; aqui a idade de 54 anos sem trombose define baixo risco.

D) Flebotomias (hematócrito abaixo de 45%) e AAS CORRETA
Correta. Policitemia vera de baixo risco (menos de 60 anos e sem trombose): flebotomia com alvo de hematócrito abaixo de 45% e AAS em dose baixa.

Para levar. Na policitemia vera, o risco trombótico se define por idade de 60 anos ou mais e trombose prévia; no baixo risco, flebotomia com hematócrito abaixo de 45% e AAS, sem citorredução por plaquetose moderada ou fatores de risco cardiovascular.

European LeukemiaNet 2021 (Marchetti et al., Lancet Haematol 2022); CYTO-PV (Marchioli et al., N Engl J Med 2013); Tefferi e Barbui, Am J Hematol 2023.

7 Hepatologia · Hepatite alcoólica com MELD 18 e Maddrey abaixo de 32: abstinência e nutrição, sem corticoide

Limiar **Gabarito D**

Homem de 47 anos, etilista de cerca de 120 g de álcool por dia há 15 anos, com última dose há 5 dias, procura o pronto-socorro por icterícia progressiva há 3 semanas. Exame: Tax 37,7 °C, FC 98 bpm, PA 118 × 74 mmHg, icterícia 2+/4+, hepatomegalia dolorosa, sem ascite ao exame, sem flapping. Exames: bilirrubina total 4,0 mg/dL, AST 210 U/L, ALT 82 U/L, GGT 640 U/L, tempo de protrombina 17 s (controle 12 s), INR 1,6, albumina 3,0 g/dL, creatinina 0,9 mg/dL, sódio 134 mEq/L, leucócitos 13.500/mm³. MELD 18. Hemoculturas, urocultura e radiografia de tórax sem alterações. Ultrassonografia: fígado aumentado e hiperecogênico, sem dilatação de vias biliares. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

tempo de protrombina 17 s (controle 12 s)

Resolução. Icterícia, AST maior que o dobro da ALT, leucocitose e febre baixa em etilista ativo fecham hepatite alcoólica, e o reflexo é prescrever prednisolona. Mas o corticoide só tem benefício na forma grave, definida por Maddrey de 32 ou mais ou MELD acima de 20 (ACG 2024). Aqui o Maddrey é 4,6 x (17 menos 12) mais 4,0, igual a 27, e o MELD é 18: hepatite alcoólica não grave, em que o corticoide aumenta infecção sem reduzir mortalidade. A conduta é abstinência (com tratamento do transtorno por uso de álcool), tiamina, aporte de 35 a 40 kcal/kg e 1,2 a 1,5 g/kg de proteína por dia, e reavaliação seriada, porque a doença pode se agravar nas semanas seguintes. A pentoxifilina não reduz mortalidade (STOPAH) e saiu das diretrizes, e a N-acetilcisteína só se soma à prednisolona na forma grave.

A) Pentoxifilina 400 mg três vezes ao dia
Errada. Já foi alternativa ao corticoide, mas não reduziu mortalidade no STOPAH e não é recomendada em nenhuma gravidade.

B) Prednisolona com N-acetilcisteína intravenosa
Errada. A associação reduziu mortalidade em 1 mês apenas na forma grave; não se aplica à hepatite alcoólica não grave.

C) Prednisolona 40 mg/dia por 28 dias ARMADILHA
Errada. É a conduta da hepatite alcoólica grave (Maddrey de 32 ou mais, MELD acima de 20, sem infecção ativa); aqui o Maddrey é 27 e o MELD 18.

D) Abstinência e suporte nutricional CORRETA
Correta. Maddrey 27 e MELD 18 definem forma não grave: abstinência, tiamina, nutrição e vigilância, sem corticoide.

Para levar. Corticoide na hepatite alcoólica só com Maddrey de 32 ou mais ou MELD acima de 20, sem infecção ativa; abaixo disso, abstinência e nutrição.

ACG Clinical Guideline: Alcohol-Associated Liver Disease (2024); AASLD Practice Guidance: Diagnosis and Treatment of Alcohol-Associated Liver Diseases (2019); EASL Clinical Practice Guidelines: Management of alcohol-related liver disease (2018)

8 Imunologia · Imunodeficiência comum variável com bronquiectasias e giardíase: dosar imunoglobulinas antes do teste do suor

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 29 anos é encaminhado por infecções respiratórias de repetição desde os 22 anos: quatro pneumonias com internação, sinusites a cada 2 ou 3 meses e otites médias. Há 1 ano tem diarreia aquosa crônica, com perda de 6 kg; o parasitológico mostrou Giardia lamblia, tratada duas vezes, com recidiva. Nunca fumou. Sem consanguinidade entre os pais, sem infertilidade conhecida. Exame físico: IMC 19 kg/m², estertores em bases, baqueteamento digital discreto e baço palpável a 2 cm do rebordo costal. TC de tórax: bronquiectasias cilíndricas em lobos inferiores. Hemograma: leucócitos 6.200/mm³ (linfócitos 1.400/mm³), plaquetas 140.000/mm³. Anti-HIV (quarta geração) não reagente. Eletroforese de proteínas séricas: albumina 3,8 g/dL, fração gama 0,3 g/dL (VR 0,7 a 1,6). O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

fração gama 0,3 g/dL (VR 0,7 a 1,6)

Resolução. Bronquiectasias, diarreia com perda de peso e baqueteamento num adulto jovem formam o rótulo da fibrose cística de apresentação tardia, e o teste do suor parece o passo natural. Mas o padrão de germes conta outra história: pneumonias, sinusites e otites por encapsulados mais giardíase recidivante é a assinatura da deficiência de anticorpos, e a eletroforese já mostra a fração gama em menos da metade do limite inferior, com albumina normal (o que afasta perda proteica intestinal ou renal como causa da hipogamaglobulinemia). Esplenomegalia e plaquetas discretamente baixas também pertencem à imunodeficiência comum variável, que cursa com hiperplasia linfoide e autoimunidade. O passo seguinte é quantificar IgG, IgA e IgM; com IgG baixa e IgA ou IgM baixas, segue-se a resposta vacinal e a imunofenotipagem de linfócitos B, depois de afastadas causas secundárias (drogas, linfoma, perda proteica). A bronquiectasia aqui é consequência das infecções, e não doença primária das vias aéreas.

A) Teste do suor com dosagem de cloro ARMADILHA
Errada. Seria o exame com bronquiectasias, má absorção pancreática e infertilidade, sem hipogamaglobulinemia; aqui a fração gama baixa e a giardíase apontam para deficiência de anticorpos.

B) Dosagem sérica de IgG, IgA e IgM CORRETA
Correta. A fração gama de 0,3 g/dL com albumina normal exige quantificar as imunoglobulinas, primeiro passo do diagnóstico da imunodeficiência comum variável.

C) Dosagem sérica de alfa-1 antitripsina
Errada. A deficiência de alfa-1 antitripsina dá enfisema panacinar de bases e hepatopatia, não infecções por encapsulados com giardíase.

D) Biópsia de mucosa nasal para cílios
Errada. Discinesia ciliar primária começa na infância, com situs inversus em metade dos casos e otite crônica, e não reduz a fração gama.

Para levar. Infecções sinopulmonares por encapsulados com giardíase e fração gama baixa pedem dosagem de IgG, IgA e IgM antes de qualquer exame de doença de via aérea.

ESID Registry working definitions for clinical diagnosis of inborn errors of immunity (2019); AAAAI/ACAAI Practice parameter for the diagnosis and management of primary immunodeficiency (2015).

9

Nefrologia · Hipercalemia no tratamento da pneumocistose · trimetoprima em dose alta bloqueia o ENaC, e não insuficiência adrenal

Droga a deduzir **Gabarito B**

Homem de 41 anos, com infecção pelo HIV diagnosticada há 10 dias (CD4 de 62 células/mm³), está internado há 6 dias por pneumonia intersticial bilateral com PaO2 de 64 mmHg em ar ambiente e LDH elevada, tratado com o esquema de primeira linha para o agente mais provável, em dose plena, associado a prednisona. Hoje refere fraqueza leve. PA 118/74 mmHg, FC 88 bpm, sem hiperpigmentação. Exames: potássio 6,3 mEq/L (4,1 mEq/L na admissão), sódio 134 mEq/L, cloro 108 mEq/L, bicarbonato 19 mEq/L, creatinina 1,3 mg/dL (1,0 mg/dL na admissão), glicose 132 mg/dL; cortisol sérico às 8 h, colhido na admissão, de 21 mcg/dL. ECG com ondas T apiculadas, sem alargamento do QRS. Não usa IECA, BRA, espironolactona nem heparina. O mecanismo principal da hipercalemia é:

O DADO QUE DECIDE

esquema de primeira linha para o agente mais provável, em dose plena

Resolução. O rótulo HIV com CD4 de 62 puxa para a adrenalite por citomegalovírus, mas o cortisol de 21 mcg/dL, a PA normal e a ausência de hiperpigmentação não sustentam insuficiência adrenal. O dado a deduzir é a droga: pneumonia intersticial com LDH alta e hipoxemia na aids é pneumocistose, e o esquema de primeira linha em dose plena é sulfametoxazol-trimetoprima (15 a 20 mg/kg/dia de trimetoprima). A trimetoprima tem estrutura parecida com a da amilorida e bloqueia o canal epitelial de sódio (ENaC) no ducto coletor, abolindo o gradiente elétrico que secreta potássio, o que produz hipercalemia com acidose hiperclorêmica leve em cerca de 5 a 7 dias. A pequena subida da creatinina também é esperada, porque a trimetoprima inibe a secreção tubular de creatinina sem queda real da filtração. A nefrite intersticial existiria com exantema, eosinofilia e piora franca da função, e a acidose discreta não explica um potássio de 6,3.

A) Insuficiência adrenal por citomegalovírus ARMADILHA
Errada. Seria a resposta com hipotensão, hiponatremia acentuada e cortisol baixo; aqui o cortisol de 21 mcg/dL e a PA normal a afastam.

B) Bloqueio do canal epitelial de sódio CORRETA
Correta. A trimetoprima em dose alta, deduzida do tratamento da pneumocistose, age como a amilorida no ducto coletor.

C) Nefrite intersticial aguda por sulfonamida
Errada. A sulfonamida causa nefrite intersticial, mas ela viria com exantema, eosinofilia e queda real da filtração, e não explica sozinha um potássio de 6,3 com creatinina quase estável.

D) Redistribuição pela acidose metabólica
Errada. Bicarbonato de 19 mEq/L desloca pouco potássio, e acidose hiperclorêmica (mineral) leve não sustenta esse grau de hipercalemia; a acidose aqui é consequência do mesmo bloqueio tubular.

Para levar. Sulfametoxazol-trimetoprima em dose de pneumocistose causa hipercalemia por efeito amilorida (bloqueio do ENaC) e eleva a creatinina sem lesão renal real. Vigiar potássio a partir do 3º ao 5º dia.

PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (Ministério da Saúde, com atualizações); Perazella MA. Trimethoprim-induced hyperkalaemia: clinical data, mechanism, prevention and management. Drug Saf 2000.

10 Infectologia · Síndrome mononucleose-símile com anti-EBNA reagente: citomegalovírus no adulto de meia-idade

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 41 anos, professor, em relação monogâmica com a esposa há 12 anos, procura ambulatório por febre diária até 38,6 °C há 3 semanas, astenia e sudorese. Nega dor de garganta, uso de medicamentos e viagens. Exame: bom estado geral, orofaringe sem exsudato, linfonodos cervicais de 1 cm, discretos, baço palpável a 2 cm do rebordo costal. Hemograma: leucócitos 11.800/mm³, 61% de linfócitos, 16% de linfócitos atípicos; plaquetas 128.000/mm³. ALT 168 U/L, AST 140 U/L, FA 190 U/L. Anticorpo heterófilo (monoteste) negativo no 7º e no 20º dia. Sorologias: anti-VCA IgM não reagente, anti-VCA IgG e anti-EBNA IgG reagentes; toxoplasmose IgG reagente e IgM não reagente; anti-HIV de 4ª geração não reagente. O agente etiológico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

anti-VCA IgG e anti-EBNA IgG reagentes

Resolução. Linfocitose com linfócitos atípicos, esplenomegalia e hepatite leve são verdadeiras e levam direto ao EBV. Mas o anti-EBNA IgG só aparece 6 a 8 semanas depois da infecção primária; reagente no início do quadro, com VCA IgM negativo, indica EBV antigo e praticamente exclui mononucleose por EBV agora, o que o heterófilo negativo duas vezes confirma. No adulto de meia-idade, a síndrome mononucleose-símile com febre prolongada, pouca faringite, pouca adenomegalia e hepatite é o perfil do citomegalovírus, a causa mais comum de mononucleose heterófilo-negativa; a confirmação é IgM anti-CMV (com avidez de IgG baixa, se preciso). Toxoplasmose aguda teria IgM reagente, e HIV agudo com 3 semanas de sintomas já positivaria o teste de 4ª geração, além de não haver exposição relatada.

A) Citomegalovírus CORRETA
Correta. Mononucleose heterófilo-negativa, febre arrastada, hepatite e pouca faringite com EBV antigo pelo anti-EBNA: CMV, a confirmar com IgM anti-CMV.

B) Vírus Epstein-Barr ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o quadro hematológico é compatível, mas anti-EBNA reagente com VCA IgM negativo indica infecção passada.

C) HIV, na infecção aguda
Errada. Seria a principal hipótese com exposição de risco, faringite, úlceras orais e exantema; com 3 semanas de sintomas o teste de 4ª geração já seria reagente.

D) Toxoplasma gondii
Errada. A toxoplasmose aguda daria IgM reagente e, em geral, adenomegalia mais proeminente que a hepatite.

Para levar. Anti-EBNA reagente no início do quadro exclui mononucleose aguda por EBV; mononucleose heterófilo-negativa com febre arrastada e hepatite no adulto é CMV até prova em contrário.

Harrison's Principles of Internal Medicine, 21ª ed. (2022), capítulos de EBV e CMV; Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9ª ed. (2020).

11 Neurologia · Crise de cefaleia em salvas em coronariopata deduzido pelo ticagrelor: oxigênio a 100%, não triptano

Droga a deduzir **Gabarito B**

Homem de 46 anos, tabagista, procura o pronto-socorro às 2 h da madrugada com a terceira crise do dia de dor excruciante em torno do olho direito, com lacrimejamento, rinorreia e ptose à direita; anda de um lado para o outro e não consegue ficar deitado. Há três semanas tem crises iguais, de 45 a 90 minutos, quase todas noturnas; teve um período idêntico há dois anos, que cessou sozinho em 2 meses. Usa AAS 100 mg/dia, ticagrelor 90 mg de 12/12 horas, rosuvastatina e metoprolol desde uma internação há 8 meses. PA 138/86 mmHg, FC 64 bpm, SpO2 97%. Exame neurológico normal entre as crises. Para abortar a crise atual, a medida mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

ticagrelor 90 mg de 12/12 horas

Resolução. O quadro é de cefaleia em salvas episódica (homem, dor orbitária excruciante de 45 a 90 minutos, várias por dia, autonômicos ipsilaterais, agitação, salva prévia que remitiu), e o tratamento abortivo de primeira linha que todos lembram é a sumatriptana subcutânea. O dado que derruba o triptano não está escrito como diagnóstico: a dupla antiagregação com ticagrelor iniciada numa internação há 8 meses, com estatina e betabloqueador, só se explica por síndrome coronariana aguda recente com angioplastia. Doença coronariana é contraindicação aos triptanos (vasoconstrição coronariana). Sobra o outro abortivo de primeira linha, igualmente eficaz e sem contraindicação cardiovascular: oxigênio a 100% sob máscara não reinalante, 12 a 15 L/min, por 15 a 20 minutos. Prednisona e verapamil são terapia de transição e preventiva, não abortam a crise em curso.

A) Sumatriptana 6 mg subcutânea ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria a escolha num paciente sem doença vascular; dupla antiagregação com ticagrelor denuncia síndrome coronariana recente, que contraindica triptano.

B) Oxigênio a 100% sob máscara CORRETA
Correta. Oxigênio a 100% em alto fluxo aborta a crise em 15 minutos na maioria e não tem contraindicação cardiovascular.

C) Prednisona 60 mg por via oral
Errada. Corticoide é tratamento de transição para encurtar a salva enquanto a profilaxia faz efeito; não aborta a crise atual.

D) Verapamil 80 mg por via oral
Errada. Verapamil é a profilaxia de escolha da salva (com ECG por risco de bloqueio, ainda mais com metoprolol), e não tem efeito na crise em curso.

Para levar. Crise de salvas: oxigênio a 100% em alto fluxo ou triptano subcutâneo; na coronariopatia (deduza pela droga em uso) fica o oxigênio.

EAN Guideline on the treatment of cluster headache 2023; AHS Evidence-Based Guideline 2016; ICHD-3 (2018).

12 Cardiologia · Estenose aórtica de baixo fluxo e baixo gradiente com fração de ejeção preservada: escore de cálcio valvar, e não eco com dobutamina

Limiar **Gabarito D**

Mulher de 79 anos, hipertensa há 30 anos, tem dispneia aos moderados esforços e um episódio de pré-síncope ao subir ladeira há 2 meses. Usa anlodipino e losartana, com PA bem controlada em casa. Exame: PA 128×74 mmHg, FC 72 bpm, ritmo regular, pulso carotídeo de ascensão lenta, sopro sistólico ejetivo 3+/6+ em foco aórtico com B2 hipofonética. Ecocardiograma transtorácico, com medidas revisadas por um segundo examinador: ventrículo esquerdo pequeno com septo de 14 mm, fração de ejeção de 64%, área valvar aórtica de 0,8 cm² (0,48 cm²/m²), velocidade máxima de 3,4 m/s, gradiente médio de 29 mmHg, volume sistólico indexado de 30 mL/m², valva muito calcificada e de mobilidade reduzida. Ritmo sinusal, sem outra valvopatia significativa. Para definir a gravidade da estenose, o próximo exame é:

O DADO QUE DECIDE

fração de ejeção de 64%

Resolução. Área de estenose grave (0,8 cm²) com gradiente de estenose moderada (29 mmHg, velocidade 3,4 m/s) é a discordância do baixo fluxo e baixo gradiente, e o volume sistólico indexado de 30 mL/m² (abaixo de 35) confirma o baixo fluxo. A armadilha é a resposta decorada para esse cenário, o eco com dobutamina, mas ela vale para o baixo fluxo com fração de ejeção REDUZIDA, em que a dobutamina recruta reserva contrátil e separa estenose verdadeira de pseudoestenose. Aqui a fração de ejeção é de 64%: é o baixo fluxo paradoxal, de ventrículo pequeno e hipertrófico, em que a dobutamina não aumenta o fluxo de forma útil e pode provocar obstrução intraventricular. Nesse grupo, com a PA controlada e as medidas conferidas (os dois erros que mais criam falso baixo gradiente), o exame que decide é o escore de cálcio valvar pela tomografia: acima de cerca de 1.200 UA na mulher (2.000 no homem) a estenose é muito provavelmente grave, e acima de 1.600 e 3.000, respectivamente, altamente provável. O cateterismo para gradiente invasivo fica para discordância persistente.

A) Ecocardiograma de estresse com dobutamina ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Seria a resposta com fração de ejeção abaixo de 50%, para buscar reserva contrátil; com 64% e ventrículo pequeno a dobutamina não esclarece e pode gerar obstrução.

B) Ecocardiograma transesofágico com planimetria

Errada. A planimetria pelo transesofágico mede a área anatômica, que já está no limite grave; não resolve a discordância entre área e gradiente e é pouco reprodutível em valva muito calcificada.

C) Cateterismo com medida invasiva do gradiente

Errada. O gradiente invasivo é a última etapa, quando os exames não invasivos continuam discordantes; pular para ele é o degrau a mais.

D) Escore de cálcio valvar por tomografia CORRETA

Correta. No baixo fluxo e baixo gradiente com fração de ejeção preservada, o escore de cálcio valvar pela tomografia define se a estenose é grave.

Para levar. Baixo fluxo e baixo gradiente: fração de ejeção reduzida pede eco com dobutamina; fração de ejeção preservada (paradoxal) pede escore de cálcio valvar pela tomografia, depois de controlar a PA e conferir as medidas.

Atualização das Diretrizes Brasileiras de Valvopatias 2020 (SBC); ESC/EACTS 2021 (valvular heart disease); ACC/AHA 2020 (valvular heart disease)

---

13 Pneumologia · Pneumotórax espontâneo primário no mergulhador profissional: cirurgia já no primeiro episódio

Qualificador **Gabarito D**

Homem de 24 anos, alto e magro, tabagista de 5 maços-ano, trabalha como mergulhador profissional em plataforma de petróleo. Há 10 dias teve dor torácica súbita à esquerda em repouso; a radiografia mostrou pneumotórax de 2,5 cm na altura do hilo, tratado com aspiração por agulha, com reexpansão completa e alta no mesmo dia. Hoje volta ao ambulatório assintomático, SpO2 98%, radiografia normal. A TC de tórax mostra pequenas bolhas apicais bilaterais, sem cistos difusos nem outras alterações. Foi orientado a parar de fumar e pergunta quando volta a mergulhar. Para prevenir a recorrência, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

trabalha como mergulhador profissional em plataforma de petróleo

Resolução. A regra que o candidato lembra é verdadeira: no primeiro episódio de pneumotórax espontâneo primário não se indica procedimento para prevenir recorrência, e parar de fumar é a principal medida. O comando, porém, qualifica a conduta pela prevenção, e o dado da profissão muda a regra: em quem tem exposição ocupacional a variações de pressão (mergulhador, piloto), uma recorrência pode ser fatal, e a diretriz indica cirurgia definitiva já após o primeiro episódio. A técnica de escolha é a videotoracoscopia com pleurectomia (com ressecção das bolhas), que tem a menor taxa de recorrência. A pleurodese química pelo dreno é inferior e reservada a quem não pode ser operado. Mesmo após a cirurgia, a liberação para mergulho exige avaliação especializada.

A) Apenas cessação do tabagismo ARMADILHA
Errada. Seria a conduta no primeiro episódio de um paciente sem profissão de risco. Para o mergulhador profissional a recorrência é inaceitável.

B) Pleurodese com talco pelo dreno
Errada. Pleurodese química pelo dreno tem recorrência maior que a cirurgia e fica para quem não tolera operação ou recusa a cirurgia.

C) Tomografia anual das bolhas
Errada. Seguir bolhas com tomografia não previne nada e não muda conduta; bolhas apicais pequenas são o achado esperado.

D) Videotoracoscopia com pleurectomia CORRETA
Correta. Profissão com variação de pressão indica cirurgia definitiva já no primeiro episódio: videotoracoscopia com pleurectomia.

Para levar. Pneumotórax espontâneo primário: procedimento antirrecorrência só a partir do segundo episódio, EXCETO em profissões de risco (mergulho, aviação), em que a videotoracoscopia com pleurectomia se indica no primeiro.

BTS Guideline for Pleural Disease 2023; ERS/EACTS statement on primary spontaneous pneumothorax 2015.

---

14 Endocrinologia · Hipoglicemia pós-prandial com insulina muito alta após suplemento para neuropatia: síndrome autoimune insulínica (Hirata), e não insulinoma

Droga a deduzir **Gabarito C**

Homem de 58 anos, sem diabetes, procura atendimento por episódios de sudorese, tremor e confusão há 5 semanas, que ocorrem 2 a 3 horas após o almoço e, duas vezes, de madrugada. Em um episódio no pronto-socorro, a glicemia capilar foi de 38 mg/dL, com melhora imediata após glicose venosa. Tem neuropatia periférica atribuída ao alcoolismo pregresso (abstinente há 3 anos) e, há 2 meses, começou por conta própria um suplemento antioxidante vendido em farmácia para "formigamento nos pés". Nega uso de insulina ou de comprimidos para diabetes, e ninguém na casa é diabético. Exame físico sem alterações. Em nova hipoglicemia documentada (glicose plasmática de 42 mg/dL): insulina 1.850 µUI/mL (VR 2 a 25), peptídeo C 6,8 ng/mL (VR 0,9 a 4,0), pesquisa de sulfonilureias no plasma negativa. Tomografia de abdome com contraste sem alterações. A causa mais provável das hipoglicemias é:

O DADO QUE DECIDE

insulina 1.850 µUI/mL

Resolução. Hipoglicemia com insulina e peptídeo C altos fecha hiperinsulinismo endógeno, e o reflexo é insulinoma, que puxa a tomografia e o jejum de 72 horas. Mas dois dados não cabem no tumor. O primeiro é a magnitude: insulina acima de 1.000 µUI/mL é muito acima do que um insulinoma produz, e, convertida em pmol/L (cerca de 11.000), supera o peptídeo C molar (cerca de 2.250), relação maior que 1, que só existe quando um anticorpo prende a insulina e prolonga sua meia vida. O segundo é o padrão: crises pós-prandiais e de madrugada, porque a insulina ligada ao anticorpo depois da refeição é liberada horas mais tarde. O gatilho está escondido no suplemento antioxidante para neuropatia: ácido alfa-lipoico, composto com grupo sulfidrila (como metimazol e captopril), que induz a síndrome autoimune insulínica de Hirata em predispostos. Confirma-se com anticorpo anti-insulina, e a conduta é suspender o suplemento, com refeições fracionadas pobres em carboidrato simples; a maioria remite em meses.

A) Insulinoma pancreático ARMADILHA
Errada. É a armadilha: insulinoma dá hipoglicemia de jejum, com insulina inapropriadamente alta mas modesta e relação insulina/peptídeo C molar menor que 1; seria a resposta com insulina de 15 µUI/mL e crise após jejum prolongado.

B) Uso sub-reptício de insulina
Errada. A insulina exógena suprime o peptídeo C; aqui ele está alto, o que afasta a fonte externa.

C) Anticorpos contra a insulina CORRETA
Correta. Insulina acima de 1.000 com relação molar insulina/peptídeo C maior que 1, crises pós-prandiais tardias e um composto sulfidrila em uso (ácido alfa-lipoico): síndrome de Hirata.

D) Anticorpos contra o receptor de insulina

Errada. A síndrome do anticorpo contra o receptor (resistência insulínica tipo B) pode dar hipoglicemia, mas com peptídeo C baixo, acantose e, em geral, lúpus ou outra autoimunidade associada.

Para levar. Hiperinsulinismo com insulina acima de 1.000 µUI/mL e relação molar insulina/peptídeo C maior que 1 é anticorpo anti-insulina até prova em contrário; procure droga com sulfidrila (ácido alfa-lipoico, metimazol, captopril) antes de procurar tumor.

Endocrine Society 2009 (Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders); Censi S et al., Ann Transl Med 2018 (Insulin autoimmune syndrome: from diagnosis to clinical management).

---

15 Hepatologia · Hepatite crônica no transplantado renal com anti-HEV IgM negativo: HEV-RNA por PCR

Negativo no meio · Gabarito B

Homem de 52 anos, transplantado renal há 4 anos, em uso de tacrolimo (nível sérico de 6 ng/mL, na faixa-alvo), micofenolato de mofetila e prednisona 5 mg/dia, sem medicação nova há mais de um ano, tem ALT entre 160 e 240 U/L em todas as dosagens dos últimos 5 meses (antes, sempre normal). Está assintomático; não consome álcool. Exames: AST 140 U/L, fosfatase alcalina e bilirrubinas normais, INR 1,0, creatinina estável em 1,3 mg/dL. HBsAg e anti-HBc não reagentes; anti-HCV não reagente e HCV-RNA indetectável; CMV-PCR indetectável; anti-HEV IgM e IgG não reagentes. Ultrassonografia com Doppler hepático normal. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

anti-HEV IgM e IgG não reagentes

Resolução. A sorologia negativa para hepatite E parece encerrar a hipótese, e com as virais descartadas sobra a biópsia para procurar rejeição, droga ou hepatite autoimune. Mas em imunossuprimidos a sorologia anti-HEV tem baixa sensibilidade (o paciente pode não produzir anticorpos), e a hepatite E genótipo 3, adquirida por carne suína malcozida, é a principal causa de hepatite crônica viral nova em transplantados de órgão sólido, com risco de cirrose em poucos anos. O diagnóstico nesse grupo se faz por HEV-RNA no sangue ou nas fezes. Hepatite persistente por mais de 3 meses com PCR positivo define a forma crônica; o tratamento é reduzir a imunossupressão (principalmente o tacrolimo) e, sem clareamento, ribavirina por 3 meses. A biópsia viria se a PCR fosse negativa, e o nível de tacrolimo na faixa e a ausência de droga nova enfraquecem a hepatotoxicidade.

A) Colangiorressonância magnética

Errada. Investiga colestase por doença biliar; o padrão aqui é hepatocelular, com fosfatase alcalina normal e Doppler normal.

B) HEV-RNA por PCR no sangue CORRETA

Correta. No imunossuprimido a sorologia anti-HEV pode ser negativa; a PCR para HEV-RNA define a hepatite E crônica.

C) FAN e anticorpo antimúsculo liso

Errada. Hepatite autoimune de novo pode ocorrer, mas é menos provável que hepatite E em transplantado e não seria o primeiro exame com a PCR viral pendente.

D) Biópsia hepática percutânea ARMADILHA

Errada. Seria o passo para hepatite crônica sem causa após exames não invasivos completos; aqui falta o teste que o imunossuprimido exige para hepatite E.

Para levar. Transplantado com ALT elevada persistente: pesquisar hepatite E por PCR (HEV-RNA), porque a sorologia pode ser negativa na imunossupressão.

EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis E virus infection (2018); KDIGO Clinical Practice Guideline for the Care of Kidney Transplant Recipients (2009)

---

16 Hematologia · Pancitopenia com esplenomegalia e punção seca: monocitopenia aponta leucemia de células pilosas, não mielofibrose

Dado omitido **Gabarito A**

Homem de 54 anos, com fadiga há 5 meses e duas pneumonias tratadas no período, refere peso no hipocôndrio esquerdo. Sem febre atual, sem sudorese noturna, sem linfonodomegalias palpáveis; baço a 12 cm do rebordo costal. Hemograma: Hb 9,4 g/dL, VCM 96 fL, leucócitos 1.900/mm³ (neutrófilos 600, linfócitos 1.300, monócitos 0/mm³), plaquetas 62.000/mm³. Esfregaço: raros linfócitos de tamanho médio com citoplasma amplo; sem dacriócitos, sem eritroblastos e sem precursores mieloides circulantes. LDH normal. A tentativa de aspirado de medula óssea resultou em punção seca. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

monócitos 0/mm³

Resolução. Punção seca com esplenomegalia volumosa evoca mielofibrose, e a banca omite de propósito a imunofenotipagem. Mas a mielofibrose primária produz leucoeritroblastose (eritroblastos e precursores mieloides no sangue) e dacriócitos, ausentes aqui. A pancitopenia com monocitopenia profunda num homem de meia-idade, com esplenomegalia, infecções e medula que não aspira (por fibrose de reticulina causada pelas células pilosas) é a leucemia de células pilosas. A confirmação vem da imunofenotipagem (CD11c, CD25, CD103 e CD123 positivos), da biópsia de medula e da mutação BRAF V600E, e o tratamento de primeira linha é a cladribina. O linfoma esplênico da zona marginal e a LLC cursam com linfocitose e monócitos preservados.

A) Leucemia de células pilosas CORRETA

Correta. Pancitopenia com monócitos ausentes, esplenomegalia e punção seca sem leucoeritroblastose: leucemia de células pilosas.

B) Linfoma esplênico da zona marginal

Errada. Também tem baço grande e linfócitos com projeções, mas cursa com linfocitose e sem monocitopenia; a medula costuma ser aspirável.

C) Leucemia linfocítica crônica

Errada. A LLC se define por linfocitose B monoclonal acima de 5.000/mm³; aqui os linfócitos são 1.300/mm³.

D) Mielofibrose primária ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Explicaria punção seca e baço, mas exigiria dacriócitos e leucoeritroblastose, que o esfregaço não mostra; não causa monocitopenia isolada.

Para levar. Pancitopenia com monocitopenia, esplenomegalia e punção seca, sem dacriócitos nem leucoeritroblastose, é leucemia de células pilosas (CD103, CD25, CD11c, BRAF V600E).

Grever et al., Consensus guidelines for hairy cell leukemia, Blood 2017; WHO Classification of Haematolymphoid Tumours, 5th edition (2022); NCCN Hairy Cell Leukemia 2025.

---

17 Reumatologia · Gota em descendente de coreanos com doença renal crônica: HLA-B*58:01 antes do alopurinol

Qualificador **Gabarito A**

Homem de 57 anos, filho de imigrantes coreanos, tem gota tofácea com quatro crises no último ano, hipertensão e doença renal crônica com taxa de filtração glomerular estimada de 42 mL/min/1,73 m². Usa losartana e anlodipino. Ácido úrico sérico de 9,8 mg/dL. Radiografia dos pés com erosões em saca-bocado no primeiro metatarsofalângico, com bordas escleróticas. O reumatologista decidiu iniciar terapia hipouricemiante com alopurinol e profilaxia com colchicina. Antes de prescrever o alopurinol, o exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

filho de imigrantes coreanos

Resolução. O comando restringe a pergunta ao que precede o alopurinol, e não ao diagnóstico, que já está feito pelos tofos e pelas erosões. A uricosúria de 24 horas atrai porque separa hiperprodutor de hipoexcretor, mas não muda a escolha da droga e o ACR recomenda contra sua realização rotineira. O alelo HLA-B*58:01 confere risco muito alto de síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica e DRESS pelo alopurinol, e sua frequência é alta em coreanos, chineses han e tailandeses (e também em afrodescendentes); a doença renal crônica multiplica esse risco. Por isso a diretriz recomenda a pesquisa do alelo antes de iniciar a droga nesses grupos, e um resultado positivo leva ao febuxostate. A G6PD é exigida antes da pegloticase, não do alopurinol.

A) Pesquisa do alelo HLA-B*58:01 CORRETA
Correta. Ascendência coreana e DRC somam risco de reação grave ao alopurinol, e a pesquisa do alelo vem antes da primeira dose.

B) Atividade da G6PD eritrocitária
Errada. A G6PD é obrigatória antes da pegloticase, pelo risco de hemólise e metemoglobinemia, e não antes do alopurinol.

C) Ácido úrico em urina de 24 horas ARMADILHA
Errada. Separa hiperprodutor de hipoexcretor, mas não muda a escolha do hipouricemiante e não é recomendada de rotina.

D) Ultrassonografia articular com duplo contorno
Errada. Seria útil para confirmar gota sem cristal identificado; aqui tofos e erosões já fecham o diagnóstico.

Para levar. Antes do alopurinol em descendentes do sudeste e leste asiático (coreanos, chineses han, tailandeses) e em afrodescendentes, pesquise o HLA-B*58:01, sobretudo com DRC.

2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout; 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout.

---

18 Infectologia · Varicela no adulto hígido: janela de 24 horas para o aciclovir oral

Limiar **Gabarito A**

Em adulto imunocompetente com varicela sem complicações, o benefício demonstrado do aciclovir oral (redução da duração da febre e do número de lesões) depende de iniciá-lo, no máximo:

O DADO QUE DECIDE

varicela sem complicações

Resolução. A janela de 72 horas é a do herpes-zóster e é a que fica na memória, por isso atrai. Na varicela, os ensaios que mostraram benefício do aciclovir oral (menos lesões, febre mais curta) começaram o tratamento nas primeiras 24 horas do exantema; depois disso o ganho é mínimo no hígido sem complicações. O adulto tem varicela mais grave que a criança, e por isso o tratamento é recomendado nele quando chega a tempo. Fora da janela, o que muda a conduta é a complicação: pneumonia, encefalite, hepatite ou imunossupressão pedem aciclovir intravenoso em qualquer momento.

A) Até 24 horas do início do exantema CORRETA
Correta. Varicela no adulto sem complicações: aciclovir oral (ou valaciclovir) nas primeiras 24 horas do exantema.

B) Enquanto houver vesículas novas
Errada. Vesículas novas indicam doença ativa, mas não definem benefício do antiviral oral no hígido; esse critério se usa no zóster.

C) Até 72 horas do início do exantema ARMADILHA
Errada. É a armadilha: 72 horas é a janela do herpes-zóster, não da varicela.

D) Não há benefício no adulto hígido
Errada. Há benefício no adulto, que tem risco maior de complicações, desde que o início seja precoce.

Para levar. Varicela: aciclovir oral até 24 horas do exantema; zóster: até 72 horas; complicação ou imunossupressão: intravenoso a qualquer tempo.

CDC. Varicella: Clinical Overview (2024); American Academy of Pediatrics. Red Book (2024), Varicella-Zoster Virus Infections.

---

19 Nefrologia · Cálculo radiotransparente de baixa densidade no diabético obeso · dissolução com citrato, e não alopurinol, quando a uricosúria é normal

Negativo no meio **Gabarito D**

Homem de 57 anos, com obesidade (IMC 34 kg/m²), diabetes tipo 2 em uso de metformina e hipertensão, teve cólica renal à esquerda há 10 dias, resolvida com analgésico. A radiografia simples de abdome não mostrou imagem radiopaca. A TC sem contraste mostra cálculo de 11 mm na pelve renal esquerda, com densidade de 380 UH, sem hidronefrose. Hoje está assintomático e afebril. Exames: creatinina 1,0 mg/dL, ácido úrico sérico 6,2 mg/dL; urina de 24 horas com volume de 1,4 L e ácido úrico urinário de 610 mg (normal até 800 mg); pH urinário de 5,0 em três amostras; urocultura negativa. A conduta mais adequada para o cálculo é:

O DADO QUE DECIDE

ácido úrico urinário de 610 mg (normal até 800 mg)

Resolução. Cálculo radiotransparente com densidade abaixo de 500 UH em diabético obeso com pH urinário persistentemente de 5,0 é cálculo de ácido úrico. O apressado associa ácido úrico a alopurinol, mas o dado no meio do caso é que a uricosúria é normal: o defeito não é excesso de ácido úrico, e sim urina ácida demais (resistência à insulina reduz a amoniogênese tubular), o que mantém o ácido úrico na forma não dissociada e insolúvel. O cálculo de ácido úrico é o único que se dissolve com tratamento clínico: alcalinizar a urina com citrato de potássio até pH de 6 a 6,5, associado a aumento da ingesta hídrica, dissolve cálculos mesmo de 1 cm sem obstrução ou infecção. Litotripsia e ureteroscopia ficam para falha da dissolução, obstrução ou infecção. Alopurinol só se acrescenta quando há hiperuricosúria ou recorrência apesar da alcalinização.

A) Litotripsia extracorpórea
Errada. Seria opção para cálculo radiopaco de pelve renal até 2 cm que não se dissolve; o de ácido úrico, radiotransparente, nem é bem localizado na fluoroscopia e se dissolve com citrato.

B) Alopurinol 300 mg/dia ARMADILHA
Errada. Seria acrescentado com hiperuricosúria ou gota; aqui o ácido úrico urinário de 610 mg é normal e o problema é o pH de 5,0.

C) Ureteroscopia flexível com laser
Errada. Indicada se houvesse obstrução, infecção, dor refratária ou falha da dissolução; nada disso está presente.

D) Citrato de potássio oral CORRETA
Correta. pH urinário de 5,0 com uricosúria normal: alcalinizar com citrato de potássio (alvo pH 6 a 6,5) dissolve o cálculo.

Para levar. Cálculo de ácido úrico (radiotransparente, menos de 500 UH, pH urinário baixo) é tratado com citrato de potássio e hidratação, que o dissolvem; alopurinol só se houver hiperuricosúria.

AUA/Endourological Society Guideline: Medical Management of Kidney Stones (2014, emendada em 2019); EAU Guidelines on Urolithiasis 2025.

20

Neurologia · Hemorragia cerebelar acima de 3 cm com deterioração e hidrocefalia: evacuação cirúrgica, não derivação ventricular isolada

Limiar **Gabarito C**

Homem de 71 anos, hipertenso com uso irregular de anlodipino, é trazido ao pronto-socorro 3 horas após cefaleia occipital súbita, vômitos repetidos e incapacidade de ficar de pé. Na admissão estava sonolento, com Glasgow 14; duas horas depois, Glasgow 11 (abertura ocular à voz, confuso, localiza a dor), com paresia do olhar conjugado para a direita e paralisia facial periférica direita. PA 186/102 mmHg, FC 58 bpm. Não usa antitrombóticos; plaquetas 210.000/mm³, INR 1,0. TC de crânio: hematoma no hemisfério cerebelar direito com 3,8 cm de maior diâmetro, apagamento do quarto ventrículo e dilatação dos cornos temporais dos ventrículos laterais. Além do controle pressórico, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

3,8 cm de maior diâmetro

Resolução. A hidrocefalia é verdadeira e chama a derivação ventricular, que resolve o problema que se vê na TC. Mas o hematoma cerebelar passa de 3 cm (cerca de 15 mL), o paciente piora (Glasgow de 14 para 11) e já há sinais de compressão do tronco (paresia do olhar e facial periférica do mesmo lado, bradicardia relativa com PA alta). Nesse cenário a diretriz da AHA/ASA de 2022 indica remoção cirúrgica imediata do hematoma por craniectomia suboccipital, com ou sem derivação associada, e recomenda NÃO fazer a derivação ventricular isolada: drenar os ventrículos laterais com a fossa posterior ainda comprimida não descomprime o tronco e pode precipitar herniação ascendente. Manitol é ponte, não tratamento, e ácido tranexâmico não tem benefício funcional demonstrado na hemorragia espontânea.

A) Manitol e nova TC em 6 horas
Errada. Seria uma ponte para a cirurgia; observar com nova TC num paciente que já perdeu três pontos de Glasgow e tem sinais de tronco desperdiça o tempo que decide o desfecho.

B) Derivação ventricular externa isolada ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Na hidrocefalia por hemorragia intraventricular sem efeito de massa na fossa posterior ela basta; no hematoma cerebelar compressivo a derivação isolada não é recomendada.

C) Evacuação suboccipital do hematoma CORRETA
Correta. Hematoma cerebelar acima de 3 cm (ou 15 mL) com deterioração, compressão de tronco ou hidrocefalia vai para evacuação cirúrgica imediata.

D) Ácido tranexâmico intravenoso
Errada. Antifibrinolítico não melhora o desfecho funcional na hemorragia intracerebral espontânea fora de estudos, e não trata a compressão.

Para levar. Hemorragia cerebelar acima de 3 cm (ou 15 mL) com piora neurológica, compressão de tronco ou hidrocefalia: craniectomia suboccipital e evacuação; derivação ventricular sozinha não basta.

AHA/ASA Guideline for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage 2022 (Greenberg et al.).

21

Cardiologia · Aneurisma de aorta abdominal na mulher: limiar de reparo eletivo menor que no homem

Limiar **Gabarito B**

Em mulher de 71 anos, ex-tabagista, assintomática, com aneurisma fusiforme de aorta abdominal infrarrenal acompanhado por ultrassonografia, crescimento de 0,3 cm no último ano e anatomia favorável, o diâmetro máximo a partir do qual se deve considerar o reparo eletivo é:

O DADO QUE DECIDE

Em mulher de 71 anos

Resolução. O número que todos decoram, 5,5 cm, é o limiar do homem, e é a armadilha. Na mulher o aneurisma rompe com diâmetros menores (a aorta é menor e o risco de ruptura para o mesmo diâmetro é cerca de quatro vezes maior), por isso as diretrizes europeia e americana consideram o reparo eletivo a partir de 5,0 cm. Os outros gatilhos de reparo independem do diâmetro: sintomas (dor abdominal ou lombar atribuível ao aneurisma) e crescimento rápido, de 1 cm ou mais em um ano (ou 0,5 cm em 6 meses). Aqui o crescimento é de 0,3 cm em um ano, abaixo do gatilho, e a decisão fica no diâmetro.

A) 4,5 cm

Errada. Abaixo de 5,0 cm na mulher assintomática e sem crescimento rápido, o risco de ruptura é menor que o risco do reparo; segue-se com imagem seriada.

B) 5,0 cm CORRETA

Correta. Na mulher, o reparo eletivo deve ser considerado a partir de 5,0 cm.

C) 5,5 cm ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. 5,5 cm é o limiar do homem; aplicá-lo à mulher deixa sem reparo a faixa de 5,0 a 5,4 cm, em que o risco de ruptura dela já supera o do procedimento.

D) 6,0 cm

Errada. Não há limiar de 6,0 cm; esperar esse diâmetro expõe a paciente a risco de ruptura alto.

Para levar. AAA: reparo eletivo a partir de 5,5 cm no homem e de 5,0 cm na mulher, ou com sintomas, ou com crescimento de 1 cm ou mais por ano.

ESC 2024 (peripheral arterial and aortic diseases); SVS 2018 (abdominal aortic aneurysm)

---

22 Pneumologia · Asma grave com bronquiectasias centrais e IgE muito alta: sensibilização a Aspergillus antes do biológico

Dado omitido **Gabarito A**

Mulher de 38 anos, asmática desde a infância, piorou no último ano apesar de budesonida-formoterol 400/12 mcg duas vezes ao dia, com técnica adequada e adesão conferida na farmácia. Recebeu três ciclos de prednisona no período e tem expectorado tampões acastanhados. Nega tabagismo e contato com aves. SpO2 96%, sibilos esparsos. Hemograma: eosinófilos 1.100/mm³. IgE total 2.400 UI/mL (referência até 100). TC de tórax: bronquiectasias centrais nos lobos superiores, algumas preenchidas por muco hiperdenso. O médico que a acompanhava já preencheu o formulário para mepolizumabe, por asma eosinofílica grave. O exame a solicitar agora é:

O DADO QUE DECIDE

bronquiectasias centrais nos lobos superiores, algumas preenchidas por muco hiperdenso

Resolução. O rótulo de asma eosinofílica grave é verdadeiro e puxa o biológico, mas o caso tem tudo da aspergilose broncopulmonar alérgica: tampões acastanhados, IgE total acima de 500, eosinofilia e bronquiectasias centrais com muco hiperdenso. Pelos critérios da ISHAM (revisão de 2024), em quem tem asma o diagnóstico exige IgE total elevada e sensibilização ao Aspergillus fumigatus, demonstrada pela IgE específica (ou teste cutâneo). É um exame de sangue simples e é o que falta. Cultura de escarro tem baixa sensibilidade e o fungo pode ser só colonização; broncoscopia não entra no diagnóstico; galactomanana serve à aspergilose invasiva. Confirmada a ABPA, o tratamento inicial é prednisolona ou itraconazol, e o biológico vira opção para as recorrências.

A) IgE específica para Aspergillus CORRETA

Correta. Com IgE total acima de 500 e bronquiectasias centrais, a sensibilização ao A. fumigatus fecha o diagnóstico de ABPA.

B) Cultura de escarro para fungos
Errada. Cultura positiva apoia, mas não é critério obrigatório e tem baixa sensibilidade; seria útil para suspeita de aspergilose crônica cavitária.

C) Broncoscopia com lavado broncoalveolar ARMADILHA
Errada. É o exame a mais: a ABPA se diagnostica por sangue e imagem; broncoscopia caberia na suspeita de infecção oportunista ou neoplasia.

D) Galactomanana sérica e hemoculturas
Errada. Galactomanana sérica é marcador de aspergilose invasiva no neutropênico, não de doença alérgica.

Para levar. Asma difícil com IgE acima de 500, eosinofilia e bronquiectasias centrais: pedir IgE específica para Aspergillus antes do biológico. O tratamento da ABPA começa com corticoide oral ou itraconazol.

ISHAM-ABPA Working Group 2024 (critérios revisados); GINA 2024 (asma difícil e grave).

---

23 Gastroenterologia · Tumor neuroendócrino gástrico tipo 1 na gastrite autoimune: ressecção endoscópica e vigilância, sem gastrectomia

Omissão **Gabarito C**

Mulher de 58 anos, com hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto, é investigada por anemia macrocítica (Hb 10,1 g/dL, VCM 112 fL) com vitamina B12 sérica de 120 pg/mL. A endoscopia mostra mucosa de corpo e fundo atrófica e três lesões polipoides de 5, 6 e 8 mm no corpo gástrico; o antro é normal. A biópsia das lesões mostra tumor neuroendócrino bem diferenciado, Ki-67 de 1%; a das áreas planas mostra gastrite atrófica de corpo com metaplasia intestinal, e a pesquisa de H. pylori é negativa. Anticorpo anticélula parietal positivo; gastrina sérica de 1.150 pg/mL (referência até 100). A ecoendoscopia mostra lesões restritas à mucosa e submucosa, sem linfonodos, e a TC de abdome não tem lesões hepáticas. Além da reposição de B12, a conduta mais adequada para as lesões é:

O DADO QUE DECIDE
Ki-67 de 1%

Resolução. A palavra tumor neuroendócrino e a gastrina acima de 1.000 puxam para tratamento grande, e é o reflexo de fazer mais. Mas o quadro tem tudo do tipo 1: gastrite atrófica autoimune de corpo, anemia por B12, anticélula parietal positivo, hipergastrinemia secundária à acloridria, lesões múltiplas e menores que 1 cm, grau 1 (Ki-67 de 1%) e sem invasão da muscular própria nem metástase. O tipo 1 tem risco de metástase muito baixo e sobrevida igual à da população geral. Lesões até 1 a 2 cm se ressecam por endoscopia (ou apenas se vigiam, se menores que 1 cm), com endoscopia de controle a cada 1 a 2 anos. Gastrectomia é para o tipo 3, esporádico e com gastrina normal, ou para invasão profunda. Antrectomia e análogo de somatostatina são opções para recidiva múltipla e incontrolável, não para o primeiro achado.

A) Análogo de somatostatina de depósito
Errada. Reduz a gastrina e o número de lesões, mas é reservado a doença multifocal recorrente; não substitui a ressecção nem é necessário aqui.

B) Antrectomia para suprimir a gastrina

Errada. Remove a fonte de gastrina e pode ser considerada em lesões múltiplas recorrentes; é degrau posterior, não a primeira conduta.

C) Ressecção endoscópica e vigilância endoscópica CORRETA

Correta. Tipo 1 grau 1, menor que 1 cm, sem invasão nem metástase: ressecção endoscópica e endoscopia de vigilância.

D) Gastrectomia total com linfadenectomia ARMADILHA

Errada. É a conduta do tumor neuroendócrino gástrico tipo 3, esporádico, com gastrina normal e maior que 2 cm; aqui as lesões são pequenas, grau 1 e restritas à submucosa.

Para levar. Tumor neuroendócrino gástrico tipo 1 (gastrite autoimune, gastrina alta, lesões pequenas e múltiplas): ressecção endoscópica e vigilância; cirurgia é para o tipo 3 ou invasão profunda.

ENETS Guidance Paper for Gastroduodenal Neuroendocrine Tumours (2023); ESMO Clinical Practice Guideline Gastroenteropancreatic NETs (2020)

24

Hematologia · Plaquetopenia no termo sem hipertensão nem hemólise: trombocitopenia gestacional e analgesia neuraxial acima de 70.000

Grade X / Y **Gabarito B**

Gestante de 31 anos, G2P1, com 37 semanas, pré-natal sem intercorrências. Plaquetas: 228.000/mm³ no primeiro trimestre, 164.000/mm³ com 28 semanas e, hoje, 84.000/mm³, sem agregados no esfregaço. Na gestação anterior, as plaquetas estavam em 96.000/mm³ no parto e se normalizaram no puerpério. Nega sangramentos, sem petéquias ou equimoses. PA 116/72 mmHg, relação proteína/creatinina urinária 0,1, AST, ALT e LDH normais, bilirrubinas normais, sem esquizócitos. Está planejado parto vaginal com analgesia peridural. O diagnóstico mais provável e a conduta quanto à analgesia são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

hoje, 84.000/mm³

Resolução. Plaquetas abaixo de 100.000 assustam e puxam para a contraindicação da peridural. O diagnóstico, porém, é de trombocitopenia gestacional: queda gradual no terceiro trimestre, contagem normal no início da gravidez, mesma evolução na gestação anterior com normalização no puerpério, nenhuma hipertensão, proteinúria, hemólise ou lesão hepática que sugira pré-eclâmpsia ou HELLP. A PTI tende a aparecer no primeiro trimestre ou já existir antes, com contagens mais baixas. Para a analgesia neuraxial, o consenso da Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology (2021) considera o risco de hematoma espinhal muito baixo com plaquetas iguais ou acima de 70.000/mm³, desde que estáveis e sem outra coagulopatia. Com 84.000/mm³, a peridural está liberada sem tratamento prévio.

A) PTI / prednisona antes da peridural

Errada. Corticoide antes do parto é estratégia na PTI com plaquetas abaixo do limiar do procedimento; aqui o diagnóstico é outro e o limiar já foi alcançado.

B) Trombocitopenia gestacional / peridural permitida CORRETA

Correta. Queda gradual no terceiro trimestre, sem pré-eclâmpsia nem hemólise e com recorrência benigna: trombocitopenia gestacional, e 84.000/mm³ permite neuraxial.

C) Trombocitopenia gestacional / peridural contraindicada ARMADILHA

Errada, é a armadilha. O diagnóstico está certo, mas o limiar atual para neuraxial é de 70.000/mm³, e não 100.000/mm³.

D) PTI / imunoglobulina antes da peridural

Errada. Imunoglobulina é usada na PTI com plaquetas muito baixas perto do parto; nada aqui sugere PTI.

Para levar. Trombocitopenia gestacional: terceiro trimestre, geralmente acima de 70.000, sem hipertensão nem hemólise, e normaliza no puerpério; peridural liberada com 70.000 ou mais.

SOAP Interdisciplinary Consensus Statement 2021 (Bauer et al.) on neuraxial procedures in obstetric patients with thrombocytopenia; ACOG Practice Bulletin 207 (2019) Thrombocytopenia in Pregnancy.

25

Endocrinologia · Hiperparatireoidismo normocalcêmico: excluir deficiência de vitamina D antes de localizar a paratireoide

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 63 anos, com osteoporose diagnosticada há 2 meses (T-escore de -2,7 no colo do fêmur), sem fraturas, é encaminhada por PTH elevado. Nega nefrolitíase, uso de lítio ou de tiazídico. Refere dieta pobre em laticínios e pouca exposição solar; usa omeprazol há 6 anos. Exames: cálcio total 9,6 mg/dL (VR 8,5 a 10,2), cálcio iônico 1,22 mmol/L (VR 1,12 a 1,32), albumina 4,1 g/dL, fósforo 2,9 mg/dL, PTH 112 pg/mL (VR 15 a 65), creatinina 0,8 mg/dL (TFG estimada de 78 mL/min/1,73 m²), fosfatase alcalina no limite superior, calciúria de 24 horas 72 mg. Para seguir a investigação, o próximo exame a ser solicitado é:

O DADO QUE DECIDE

Refere dieta pobre em laticínios e pouca exposição solar

Resolução. Osteoporose com PTH alto é rótulo verdadeiro de hiperparatireoidismo primário, e o reflexo é localizar o adenoma. Mas o cálcio total e o iônico estão normais, e PTH alto com cálcio normal só vira hiperparatireoidismo primário normocalcêmico depois de excluídas as causas secundárias: deficiência de vitamina D (25-OH-D abaixo de 30 ng/mL), TFG abaixo de 60, diuréticos de alça, lítio, tiazídico, hipercalciúria renal e má absorção. Esta paciente tem três pistas de hiperparatireoidismo secundário: pouca ingestão de cálcio, pouca exposição solar e calciúria baixa (72 mg/24 h), além de inibidor de bomba de prótons por anos. O próximo passo é dosar a 25-hidroxivitamina D e, se baixa, repor até acima de 30 e repetir PTH e cálcio. Imagem de paratireoide não faz diagnóstico, só localiza, e é pedida apenas quando houver indicação cirúrgica.

A) Fosfatase alcalina óssea

Errada. Marca a remodelação óssea, que estará alta em qualquer hiperparatireoidismo; não distingue primário de secundário.

B) Cintilografia com sestamibi ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o sestamibi localiza um adenoma já diagnosticado e com indicação cirúrgica; feito agora, pode mostrar captação inespecífica em paciente sem hiperparatireoidismo primário.

C) Ultrassonografia cervical

Errada. Também é exame de localização, pré-operatório, e não de diagnóstico; não resolve se o PTH alto é secundário.

D) 25-hidroxivitamina D sérica CORRETA

Correta. PTH alto com cálcio normal exige excluir deficiência de vitamina D antes de chamar de primário; a calciúria baixa e a dieta pobre em cálcio apontam para causa secundária.

Para levar. Hiperparatireoidismo normocalcêmico é diagnóstico de exclusão: dose 25-OH-vitamina D, avalie TFG, drogas e calciúria antes de qualquer imagem de paratireoide.

Fifth International Workshop on Primary Hyperparathyroidism, J Bone Miner Res 2022; Bilezikian JP et al.

---

26 Infectologia · Endocardite por Enterococcus faecalis em idoso com DRC: ampicilina com ceftriaxona por 6 semanas, apesar da gentamicina sensível

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 79 anos, hipertenso, com doença renal crônica (taxa de filtração glomerular estimada de 34 mL/min/1,73 m²), submetido a ressecção transuretral de próstata há 7 semanas, é internado por febre há 3 semanas, astenia e perda de 4 kg. Exame: T 38,2 °C, PA 132 × 70 mmHg, sopro diastólico aspirativo 2+/6 em foco aórtico acessório, sem sinais de insuficiência cardíaca. Três de três hemoculturas: Enterococcus faecalis sensível a ampicilina, sem alto nível de resistência a aminoglicosídeos. Ecocardiograma transesofágico: vegetação de 7 mm na valva aórtica nativa, insuficiência aórtica leve, sem abscesso. Audiometria basal com perda neurossensorial leve. O esquema antimicrobiano e a duração mais adequados são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

taxa de filtração glomerular estimada de 34 mL/min/1,73 m²

Resolução. A ausência de alto nível de resistência é verdadeira e libera, em tese, o sinergismo com gentamicina, e os sintomas há menos de 3 meses permitiriam 4 semanas; é por isso que o esquema de manual atrai. Mas o paciente tem 79 anos, filtração de 34 mL/min e perda auditiva prévia: o aminoglicosídeo por semanas tem risco alto de nefrotoxicidade e ototoxicidade. Ampicilina com ceftriaxona dá sinergia por saturação de proteínas ligadoras de penicilina diferentes, tem eficácia equivalente e muito menos toxicidade, e é o esquema preferido para E. faecalis em valva nativa quando há disfunção renal ou risco de ototoxicidade, por 6 semanas. Duas semanas são esquema de estreptococo sensível em casos selecionados, não de enterococo. Vancomicina é reserva para alergia grave a betalactâmico ou resistência à ampicilina, e somaria duas drogas nefrotóxicas.

A) Ampicilina e gentamicina / 4 semanas ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seria opção em paciente jovem com função renal normal e sintomas há menos de 3 meses; aqui a filtração de 34 mL/min e a perda auditiva contraindicam aminoglicosídeo prolongado.

B) Ampicilina e ceftriaxona / 6 semanas CORRETA

Correta. Ampicilina com ceftriaxona por 6 semanas: sinergia sem aminoglicosídeo, preferida no idoso com DRC.

C) Ampicilina e ceftriaxona / 2 semanas

Errada. O esquema é certo, mas 2 semanas só existem para estreptococos muito sensíveis em casos selecionados; enterococo em valva nativa exige 6 semanas com ceftriaxona.

D) Vancomicina e gentamicina / 6 semanas
Errada. Vancomicina seria para alergia grave a betalactâmicos ou enterococo resistente à ampicilina; aqui é sensível, e o esquema soma nefrotoxicidade.

Para levar. Endocardite por E. faecalis sensível à ampicilina em idoso, DRC ou risco de ototoxicidade: ampicilina com ceftriaxona por 6 semanas, mesmo sem alto nível de resistência a aminoglicosídeo.

ESC Guidelines for the management of endocarditis (2023); AHA Scientific Statement on Infective Endocarditis in Adults (Baddour et al., 2015).

---

27 Farmacodermias · Síndrome de Stevens-Johnson: lamotrigina na janela de latência, e não a dipirona tomada no pródromo

Cronologia **Gabarito C**

Mulher de 41 anos, com epilepsia focal em uso de ácido valproico há 3 anos e transtorno bipolar, teve lamotrigina introduzida há 17 dias pelo psiquiatra, na dose de 50 mg/dia. Usa anlodipino há 4 anos. Há 4 dias teve febre, odinofagia e mal-estar, e tomou dipirona 1 g a cada 6 horas por 2 dias. Há 24 horas surgiram máculas purpúricas e lesões em alvo atípicas planas na face e no tronco, com bolhas flácidas, e erosões nos lábios, na mucosa oral e nas conjuntivas. Nikolsky positivo; o destacamento epidérmico é estimado em 8% da superfície corporal. Tax 38,6 °C, FC 108 bpm, PA 112 × 70 mmHg. O fármaco mais provavelmente responsável é:

O DADO QUE DECIDE
teve lamotrigina introduzida há 17 dias

Resolução. A dipirona é a última droga tomada e a mais lembrada, mas foi usada para tratar o pródromo febril da própria síndrome, e uma latência de 2 a 4 dias é curta demais para a primeira exposição: é o viés protopático. Na síndrome de Stevens-Johnson, a droga culpada é quase sempre uma iniciada entre 5 e 28 dias antes (critério de latência do algoritmo ALDEN), e a lamotrigina, começada há 17 dias, cai exatamente nessa janela. O valproico, usado há 3 anos, não causa a reação por si nesse tempo, mas explica por que ela ocorreu: inibe a glicuronidação da lamotrigina e dobra seu nível, e por isso a titulação com valproico começa com 25 mg em dias alternados; 50 mg/dia foi dose excessiva. O anlodipino, em uso há anos, tem risco desprezível. Com 8% de destacamento e mucosas acometidas, é síndrome de Stevens-Johnson (menos de 10%), e a conduta central é suspender a lamotrigina e nunca reexpô-la.

A) Ácido valproico
Errada. Em uso há 3 anos, fora da janela de latência; seu papel é elevar o nível da lamotrigina, não causar a reação.

B) Dipirona ARMADILHA
Errada. Seria suspeita se tivesse sido iniciada 5 a 28 dias antes; tomada no pródromo, com latência de 2 dias, é viés protopático.

C) Lamotrigina CORRETA
Correta. Iniciada há 17 dias, em dose alta para quem usa valproico, está na janela de 5 a 28 dias e é droga de alto risco.

D) Anlodipino
Errada. Droga de baixo risco e em uso há 4 anos; seria considerada apenas se tivesse sido introduzida nas últimas semanas.

Para levar. Na SSJ/NET, procure a droga iniciada entre 5 e 28 dias antes; a usada para tratar o pródromo febril costuma ser inocente.

Algoritmo ALDEN (Sassolas et al., 2010); British Association of Dermatologists guidelines for SJS/TEN in adults (2016).

---

28 Gastroenterologia · Colecistite aguda acalculosa em paciente crítico instável: colecistostomia percutânea, e não colecistectomia

Grade X / Y **Gabarito A**

Mulher de 66 anos está no 10º dia de UTI por choque séptico de foco pulmonar, em ventilação mecânica, nutrição parenteral total desde a admissão e noradrenalina 0,25 mcg/kg/min, que vinha em redução e voltou a subir há 24 horas. Recebe meropenem e vancomicina há 7 dias, com hemoculturas de controle negativas e radiografia de tórax em melhora. Hoje: Tax 38,6 °C, leucócitos 19.800/mm³, bilirrubina total 2,3 mg/dL, fosfatase alcalina 240 U/L. A ultrassonografia à beira do leito mostra vesícula distendida (11 × 5 cm), com parede de 5,5 mm com líquido pericolecístico, lama biliar, sem cálculos e sem dilatação de vias biliares. Quanto ao diagnóstico e à conduta, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

parede de 5,5 mm com líquido pericolecístico

Resolução. Lama e vesícula distendida são esperadas em quem está em jejum e nutrição parenteral há dias, e é fácil atribuir o achado ao jejum e procurar a febre em outro lugar. Mas parede espessada acima de 3,5 mm com líquido pericolecístico, febre nova, leucocitose e piora hemodinâmica num paciente crítico configuram colecistite aguda acalculosa, que evolui com gangrena e perfuração em até metade dos casos. Decidida a doença, a outra metade é o porte da intervenção: com noradrenalina em ascensão e ventilação mecânica, a colecistectomia de urgência tem mortalidade alta, e a colecistostomia percutânea guiada por imagem drena o foco à beira do leito com sucesso na maioria. A colecistectomia fica para depois da recuperação, se indicada, ou para gangrena e perfuração. O antibiótico em curso já cobre a flora biliar.

A) Colecistite aguda acalculosa / colecistostomia percutânea CORRETA
Correta. Parede espessada com líquido pericolecístico e febre em paciente crítico é colecistite acalculosa; instável, drena-se por colecistostomia percutânea.

B) Colecistite aguda acalculosa / colecistectomia de urgência ARMADILHA
Errada. O diagnóstico está certo, mas a colecistectomia é a conduta do paciente estável ou da perfuração; com choque em ascensão, o risco operatório é proibitivo.

C) Lama biliar do jejum / manter e repetir ultrassonografia
Errada. Seria a conduta da lama isolada sem inflamação; parede espessada com líquido pericolecístico e febre nova não são do jejum.

D) Lama biliar do jejum / ácido ursodesoxicólico
Errada. O ursodesoxicólico não trata infecção nem inflamação da vesícula, e a hipótese de lama simples ignora os sinais inflamatórios.

Para levar. Colecistite acalculosa no paciente crítico instável: colecistostomia percutânea e antibiótico; colecistectomia só com estabilidade ou complicação.

Tokyo Guidelines 2018 (TG18) para colecistite aguda; ACR Appropriateness Criteria Right Upper Quadrant Pain (2022)

---

29 Nefrologia · Hipernatremia crônica com choque hipovolêmico no idoso · cristaloide isotônico primeiro e teto de queda do sódio

Grade X / Y **Gabarito A**

Mulher de 86 anos, com doença de Alzheimer avançada, acamada e institucionalizada, é trazida por sonolência progressiva há 3 dias. A cuidadora relata febre e recusa de líquidos há cerca de 5 dias. Usa donepezila e quetiapina. Exame: sonolenta, desperta ao chamado, sem déficit focal, mucosas muito secas, PA 82/50 mmHg, FC 118 bpm, tempo de enchimento capilar de 5 segundos, temperatura 37,9 °C. Exames: sódio 164 mEq/L, potássio 3,8 mEq/L, ureia 112 mg/dL, creatinina 1,7 mg/dL (basal 0,8 mg/dL), glicose 118 mg/dL; EAS com leucocitúria e nitrito positivo. Quanto ao fluido inicial e ao limite de queda do sódio sérico nas primeiras 24 horas, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

PA 82/50 mmHg

Resolução. A armadilha é tratar o número: sódio de 164 lembra déficit de água livre, e o reflexo é soro glicosado a 5%. Mas a paciente está em choque hipovolêmico (PA 82/50 mmHg, enchimento capilar de 5 segundos, ureia desproporcional), e a prioridade é restaurar a perfusão com cristaloide isotônico, que se distribui no extracelular; o glicosado vai em dois terços para dentro das células e não sustenta a pressão. O SF 0,9% (154 mEq/L) ainda é hipotônico em relação ao plasma dela, então já começa a baixar o sódio sem risco de queda brusca. Só depois de estabilizada a hemodinâmica se passa para fluido hipotônico, calculando o déficit de água. Como a hipernatremia se instalou ao longo de dias (crônica, mais de 48 horas), o cérebro já gerou osmólitos, e a queda não deve passar de cerca de 10 mEq/L em 24 horas para evitar edema cerebral. A segunda metade separa quem sabe que a correção rápida só é tolerada na hipernatremia aguda, de horas.

A) SF 0,9% / até 10 mEq/L CORRETA

Correta. Choque (PA 82/50 mmHg) pede cristaloide isotônico antes da água livre, e a evolução de dias define hipernatremia crônica, com teto de cerca de 10 mEq/L em 24 horas.

B) Soro glicosado a 5% / até 10 mEq/L ARMADILHA

Errada. O teto está certo, mas soro glicosado seria o fluido de escolha na paciente normotensa, para repor água livre; em choque ele não expande o intravascular.

C) SF 0,9% / até 20 mEq/L

Errada. O fluido está certo, mas 20 mEq/L em 24 horas só se aceitaria na hipernatremia aguda, de poucas horas (por exemplo, sobrecarga de sal); aqui são dias de evolução.

D) Soro glicosado a 5% / até 20 mEq/L

Errada. Erra as duas metades: água livre em choque e velocidade de correção de hipernatremia aguda numa crônica.

Para levar. Hipernatremia com instabilidade hemodinâmica: SF 0,9% primeiro, água livre depois. Se crônica (mais de 48 horas ou duração incerta), baixar no máximo cerca de 10 mEq/L em 24 horas.

Adrogué HJ, Madias NE. Hypernatremia. N Engl J Med 2000; Sterns RH. Disorders of plasma sodium: causes, consequences, and correction. N Engl J Med 2015.

---

30 Neurologia · Terceira piora depois de 8 semanas numa suposta síndrome de Guillain-Barré: polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica de início agudo

Cronologia **Gabarito A**

Mulher de 44 anos teve, há 10 semanas, fraqueza ascendente simétrica com arreflexia, que atingiu o nadir no 12º dia (não deambulava sem apoio); o líquor mostrou proteína de 148 mg/dL e 3 células/mm³, e a eletroneuromiografia, padrão desmielinizante. Recebeu imunoglobulina humana IV 2 g/kg, com melhora parcial. Na 5ª semana piorou e recebeu novo ciclo, com melhora; na 8ª semana, nova piora, tratada com plasmaférese. Hoje, na 10ª semana, procura o ambulatório com a terceira piora: volta a não subir escadas, com parestesias em luvas e botas e arreflexia global. Sem disautonomia, sem queixas respiratórias (CVF 2,9 L), afebril. Anti-HIV, eletroforese de proteínas com imunofixação e glicemia de jejum normais. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

Hoje, na 10ª semana, procura o ambulatório com a terceira piora

Resolução. O início foi indistinguível de síndrome de Guillain-Barré, e piora depois da imunoglobulina tem nome conhecido: flutuação relacionada ao tratamento, que ocorre em cerca de 10% e responde a novo ciclo. A flutuação, porém, tem limites: acontece dentro das primeiras 8 semanas e no máximo duas vezes. Piora depois de 8 semanas do início, ou três ou mais flutuações, define polineuropatia (polirradiculoneuropatia) desmielinizante inflamatória crônica de início agudo (cerca de 5% das que começam como Guillain-Barré). A consequência é prática: a doença crônica responde a corticoide (o Guillain-Barré não) e exige terapia de manutenção (corticoide, imunoglobulina periódica ou subcutânea). A imunofixação normal afasta POEMS, e um novo Guillain-Barré exigiria recuperação completa e intervalo longo.

A) Polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica CORRETA
Correta. A terceira piora, depois da 8ª semana, cumpre o critério de início agudo da forma crônica, que passa a ter corticoide e manutenção como tratamento.

B) Novo episódio de síndrome de Guillain-Barré
Errada. Recorrência de Guillain-Barré é rara e vem após recuperação completa e intervalo de meses ou anos, não em piora contínua por 10 semanas.

C) Flutuação relacionada ao tratamento com imunoglobulina ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Flutuação relacionada ao tratamento é a resposta até a 8ª semana e com no máximo duas pioras; aqui são três, a última na 10ª semana.

D) Síndrome POEMS
Errada. POEMS dá polineuropatia desmielinizante refratária, mas exige proteína monoclonal lambda, ausente na imunofixação normal.

Para levar. Guillain-Barré que piora após 8 semanas ou que flutua três ou mais vezes é polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica: muda para corticoide e manutenção.

EAN/PNS Guideline on chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy 2021 (Van den Bergh et al.); EAN/PNS Guideline on Guillain-Barré syndrome 2023.

---

31 Cardiologia · Síndrome de Williams: estenose aórtica supravalvar com diferença de PA entre os braços, e não coarctação

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 24 anos é levado pela mãe para avaliar hipertensão detectada em exame admissional. Teve atraso do desenvolvimento, estudou em escola especial e é descrito como muito comunicativo e afetuoso com estranhos; a mãe lembra que, no primeiro ano de vida, ele foi internado por irritabilidade e vômitos, com 'cálcio alto no sangue'. Ao exame: baixa estatura, nariz curto e arrebitado, lábios grossos, boca larga e íris com padrão estrelado. PA 158×88 mmHg no braço direito e 134×84 mmHg no braço esquerdo; pulsos femorais amplos e simétricos, sem retardo radiofemoral. Frêmito sistólico na fúrcula e sopro sistólico ejetivo rude, mais intenso no 1º espaço intercostal direito e irradiado para as carótidas, sem clique de ejeção; componente aórtico de B2 normal. Creatinina 0,8 mg/dL e potássio 4,2 mEq/L. A lesão cardiovascular mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

pulsos femorais amplos e simétricos, sem retardo radiofemoral

Resolução. Jovem hipertenso com PA maior num braço puxa para a coarctação, e essa é a isca. Mas a coarctação se denuncia pelos membros inferiores (pulsos femorais fracos e atrasados, PA da perna menor que a do braço), e aqui os femorais são amplos e sem retardo. O conjunto de deficiência intelectual leve, personalidade hipersociável, hipercalcemia na infância, face com nariz arrebitado e lábios grossos e íris estrelada é a síndrome de Williams (deleção em 7q11.23, que inclui o gene da elastina), cuja lesão cardíaca característica é a estenose aórtica supravalvar. Nela o jato é dirigido para o tronco braquiocefálico (efeito Coanda), o que explica PA maior no braço direito, frêmito na fúrcula e sopro mais alto no 1º espaço direito. A ausência de clique ejetivo e o A2 preservado falam contra estenose valvar (bicúspide), cuja valva móvel gera clique. A hipertensão do Williams tem ainda contribuição da estenose de artérias renais e da rigidez arterial pela arteriopatia da elastina.

A) Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva
Errada. O sopro da CMH obstrutiva é mesossistólico na borda esternal esquerda, aumenta com Valsalva e não irradia para as carótidas nem gera frêmito na fúrcula ou assimetria de PA entre os braços.

B) Valva aórtica bicúspide estenótica
Errada. A bicúspide é a lesão da síndrome de Turner e cursa com clique ejetivo aórtico; aqui não há clique e o A2 é normal, e a bicúspide não cria diferença de PA entre os braços.

C) Estenose aórtica supravalvar CORRETA
Correta. A síndrome de Williams (hipercalcemia infantil, fácies e personalidade descritas) cursa com estenose supravalvar, e o efeito Coanda explica a PA maior no braço direito e o frêmito na fúrcula.

D) Coarctação da aorta ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria a resposta com PA maior nos braços do que nas pernas, pulsos femorais fracos e atrasados e sopro interescapular; aqui os femorais são amplos e sem retardo, e a diferença é entre os dois braços.

Para levar. Williams (hipercalcemia infantil, personalidade hipersociável, íris estrelada): estenose aórtica supravalvar, com PA maior no braço direito por efeito Coanda; coarctação é braço maior que perna, com femorais fracos.

ESC 2020 (adult congenital heart disease); Diretriz ACC/AHA 2018 para cardiopatia congênita do adulto; Pober BR, N Engl J Med 2010 (síndrome de Williams-Beuren)

---

32 Hematologia · Neutropenia estável em mulher negra assintomática: neutropenia associada ao fenótipo Duffy nulo, sem investigação adicional

Omissão **Gabarito B**

Mulher de 34 anos, negra, faz exame admissional. Hemograma: leucócitos 2.900/mm³ (neutrófilos 1.050, linfócitos 1.500, monócitos 280/mm³), Hb 13,1 g/dL, VCM 88 fL, plaquetas 236.000/mm³, esfregaço sem alterações morfológicas. Assintomática, nega infecções de repetição, úlceras orais, artralgias, perda de peso e uso de medicamentos. Exame físico sem esplenomegalia ou linfonodomegalias. Trouxe hemogramas de 2019, 2022 e 2024, todos com neutrófilos entre 1.000 e 1.300/mm³. A irmã tem "glóbulos brancos baixos". Anti-HIV, HBsAg, anti-HCV, vitamina B12 e TSH normais. Quanto à investigação, o próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

todos com neutrófilos entre 1.000 e 1.300/mm³

Resolução. Neutropenia num adulto faz pensar em doença de medula, e o reflexo é o mielograma. Mas o quadro tem todos os elementos da neutropenia associada ao fenótipo Duffy nulo (antes chamada neutropenia étnica benigna): mulher negra, neutropenia leve (acima de 1.000/mm³) estável há anos, familiar com o mesmo achado, nenhuma infecção, outras séries e morfologia normais, sem baço e sem drogas. É uma variante da normalidade presente em grande parte das pessoas de ascendência africana, sem aumento de risco infeccioso. A conduta é não investigar mais e apenas acompanhar; a fenotipagem Duffy pode documentar o achado, mas não é obrigatória. Mielograma, anticorpo antineutrófilo e pesquisa de grandes linfócitos granulares ficam para neutropenia nova, progressiva, grave ou com infecções.

A) Mielograma com citogenética ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria o exame com citopenias em mais de uma série, morfologia displásica ou neutropenia progressiva; aqui a neutropenia é leve, isolada e estável há 5 anos.

B) Nenhum exame, apenas hemograma periódico CORRETA
Correta. Neutropenia leve, estável e familiar em mulher negra assintomática: variante associada ao Duffy nulo, sem investigação adicional.

C) Pesquisa de anticorpo antineutrófilo
Errada. A neutropenia autoimune entra com infecções, doença autoimune ou contagens oscilantes e mais baixas.

D) Imunofenotipagem para grandes linfócitos granulares
Errada. A leucemia de grandes linfócitos granulares se pesquisa com neutropenia grave, artrite reumatoide ou esplenomegalia, nada disso presente.

Para levar. Neutropenia leve (acima de 1.000), isolada, estável e assintomática em pessoa de ascendência africana é variante Duffy nulo: não se investiga além do básico.

Merz et al., ACKR1/Duffy-null associated neutrophil count, Am J Hematol 2023; Atallah-Yunes et al., Benign ethnic neutropenia, Blood Rev 2019.

---

33 Pneumologia · TEP na gestante com sinais de TVP: ultrassonografia venosa antes de irradiar o tórax, e heparina de baixo peso

Grade X / Y **Gabarito C**

Mulher de 31 anos, com 24 semanas de gestação, procura a emergência por dispneia aos moderados esforços e dor pleurítica à direita há dois dias. Nega febre e tosse. Sem comorbidades, usa apenas sulfato ferroso. Exame: PA 112 × 70 mmHg, FC 104 bpm, FR 22 irpm, SpO2 95% em ar ambiente, ausculta pulmonar sem alterações. A panturrilha esquerda está 3 cm mais grossa que a direita, com empastamento doloroso. Radiografia de tórax com proteção abdominal: normal. ECG: taquicardia sinusal. D-dímero 1.900 ng/mL. Função renal normal. O exame a solicitar agora e o anticoagulante a usar se o diagnóstico se confirmar são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

A panturrilha esquerda está 3 cm mais grossa que a direita

Resolução. A cintilografia atrai porque é o exame de tórax lembrado para a gestante com radiografia normal, e o medo da radiação empurra para ela. Mas este caso tem sinais clínicos de TVP no meio do exame físico, e na gestante com suspeita de TEP e sinais de TVP o primeiro exame é a ultrassonografia venosa compressiva: se mostrar trombose, o tratamento é o mesmo do TEP e nenhuma radiação é necessária. Só se o ultrassom for negativo segue-se para cintilografia ou angiotomografia. O D-dímero sobe fisiologicamente na gestação e, isolado, não decide. Confirmada a trombose, o anticoagulante é a heparina de baixo peso molecular em dose plena ajustada ao peso, que não atravessa a placenta; os anticoagulantes orais diretos são contraindicados na gestação, e a heparina não fracionada fica para quem tem disfunção renal grave ou pode precisar de procedimento imediato.

A) Angiotomografia de tórax / heparina não fracionada
Errada. Angiotomografia seria o exame com ultrassom negativo e radiografia alterada; a heparina não fracionada se reserva a insuficiência renal grave ou parto e trombólise iminentes. A panturrilha empastada pede ultrassom antes.

B) Cintilografia de ventilação e perfusão / enoxaparina ARMADILHA
Errada. A cintilografia é boa opção na gestante com radiografia normal e SEM sinais de TVP. Aqui há panturrilha 3 cm mais grossa, e o ultrassom pode dispensar qualquer radiação.

C) Ultrassonografia venosa compressiva / enoxaparina CORRETA
Correta. Sinais de TVP na gestante: ultrassom venoso primeiro; confirmada a trombose, enoxaparina em dose plena.

D) Ultrassonografia venosa compressiva / rivaroxabana
Errada. O exame está certo, mas anticoagulante oral direto atravessa a placenta e é contraindicado na gestação; seria opção após o parto em quem não amamenta.

Para levar. Na gestante com suspeita de TEP e sinais de TVP, ultrassonografia venosa compressiva primeiro; trombose confirmada dispensa imagem do tórax. Anticoagulante na gestação é heparina de baixo peso molecular, nunca DOAC ou varfarina.

ESC 2019 (embolia pulmonar aguda); ASH 2018 (tromboembolismo venoso na gestação); Diretriz Conjunta sobre Tromboembolismo Venoso SBC 2022.

---

34 Imunologia · Angioedema sem urticária em usuário de IECA com leucemia linfocítica crônica: C4 e C1q baixos indicam deficiência adquirida do inibidor de C1

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 66 anos, hipertenso em uso de enalapril 20 mg/dia há 6 anos, tem leucemia linfocítica crônica diagnosticada há 2 anos, em observação (Binet A). Apresenta o terceiro episódio em 5 meses de edema de lábios e língua, sem prurido e sem urticária, que se resolve em 3 dias. No primeiro episódio recebeu adrenalina intramuscular, prometazina e hidrocortisona, sem resposta. Há 2 meses teve dor abdominal em cólica com vômitos, e a TC mostrou espessamento de alça jejunal que regrediu em 48 horas. Nega casos semelhantes na família. Exames fora da crise: leucócitos 24.000/mm³ (82% linfócitos), C4 de 4 mg/dL (VR 10 a 40), inibidor de C1 quantitativo de 9 mg/dL (VR 21 a 39), C1q de 3 mg/dL (VR 10 a 25). A causa mais provável do angioedema é:

O DADO QUE DECIDE

C4 de 4 mg/dL (VR 10 a 40)

Resolução. Angioedema de língua, sem urticária, sem resposta a adrenalina e anti-histamínico, num hipertenso que usa IECA: o rótulo do angioedema por enalapril é verdadeiro e fortíssimo, e o tempo de uso de 6 anos não o afasta, porque essa reação pode surgir anos depois. Mas o angioedema por IECA é um excesso de bradicinina com complemento normal; ele não consome C4 nem reduz o inibidor de C1. Aqui o C4 e o inibidor de C1 estão baixos fora da crise, o que define deficiência do inibidor, e o C1q baixo separa a forma adquirida (consumo por clone linfoproliferativo ou autoanticorpo anti-C1-INH) da hereditária, em que o C1q é normal. Início após os 60 anos, ausência de história familiar e a leucemia linfocítica crônica fecham o quadro. O enalapril deve ser suspenso de qualquer forma, porque piora qualquer angioedema bradicinérgico, mas não explica o laboratório; a crise se trata com icatibanto ou concentrado de inibidor de C1, e o controle a longo prazo depende de tratar a doença linfoproliferativa.

A) Angioedema induzido pelo enalapril ARMADILHA
Errada. Seria a resposta com C4 e inibidor de C1 normais; o IECA não consome complemento, e o C4 de 4 mg/dL exige outra explicação.

B) Angioedema hereditário tipo I
Errada. O tipo I cursa com C4 e inibidor de C1 baixos, mas com C1q normal, início na infância ou adolescência e, em geral, história familiar.

C) Angioedema histaminérgico recorrente
Errada. Seria a resposta com urticária, prurido e resposta a adrenalina e anti-histamínico; aqui não houve nenhum dos três.

D) Deficiência adquirida do inibidor de C1 CORRETA
Correta. C4 e inibidor de C1 baixos com C1q baixo, após os 60 anos e com leucemia linfocítica crônica, definem a deficiência adquirida do inibidor de C1.

Para levar. No angioedema sem urticária, o C4 separa: normal com IECA aponta a droga; baixo exige dosar o inibidor de C1, e o C1q baixo indica a forma adquirida, que pede busca de doença linfoproliferativa.

Giavina-Bianchi et al., Brazilian guidelines for hereditary angioedema management (2017 update); WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema (2021 revision and update).

---

35 Endocrinologia · Cardiomiopatia acromegálica: hipertrofia biventricular concêntrica, e não a forma septal assimétrica

Qualificador **Gabarito C**

Na acromegalia ativa de longa duração, a alteração cardíaca estrutural mais frequente ao ecocardiograma, presente mesmo em normotensos, é:

O DADO QUE DECIDE

presente mesmo em normotensos

Resolução. Quem associa GH a crescimento tende a marcar a hipertrofia septal assimétrica, que é a assinatura da cardiomiopatia hipertrófica sarcomérica, outra doença. O excesso crônico de GH e IGF-1 age diretamente sobre o miócito e o interstício e produz hipertrofia concêntrica dos dois ventrículos, com aumento da massa e disfunção diastólica, independentemente da pressão arterial (daí o qualificador "mesmo em normotensos"). A história natural tem três fases: hipercinética no início, hipertrofia biventricular com disfunção diastólica na doença estabelecida, e dilatação com disfunção sistólica só no fim, quando a doença ficou muitos anos sem controle. Arritmias e valvopatia mitral e aórtica acompanham. A hipertrofia regride parcialmente com o controle bioquímico, o que torna o ecocardiograma parte da avaliação inicial.

A) Padrão restritivo de aspecto infiltrativo
Errada. Padrão restritivo infiltrativo sugere amiloidose ou sarcoidose; a acromegalia dá hipertrofia por crescimento do miócito, e não por infiltração.

B) Dilatação com fração de ejeção reduzida
Errada. É a fase final, rara hoje, de doença não controlada por muitos anos; não é a alteração mais frequente.

C) Hipertrofia biventricular concêntrica CORRETA
Correta. A cardiomiopatia acromegálica é hipertrofia concêntrica biventricular com disfunção diastólica, presente mesmo sem hipertensão.

D) Hipertrofia septal assimétrica obstrutiva ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a hipertrofia septal assimétrica com obstrução é da cardiomiopatia hipertrófica sarcomérica, e não do excesso de GH.

Para levar. Acromegalia dá hipertrofia concêntrica biventricular com disfunção diastólica, independente da pressão; a dilatação com fração de ejeção baixa é a fase tardia.

Colao A et al., Nat Rev Dis Primers 2019 (Acromegaly); Giustina A et al., J Clin Endocrinol Metab 2020 (consensus on the diagnosis and treatment of acromegaly comorbidities).

---

36 Infectologia · Antígeno criptocócico sérico reagente na pessoa com HIV assintomática: punção lombar antes de escolher o antifúngico

Negativo no meio **Gabarito C**

Homem de 34 anos teve HIV diagnosticado há 1 semana em triagem de banco de sangue. Está assintomático: nega cefaleia, febre, vômitos, alteração visual ou de comportamento. Exame: T 36,8 °C, PA 118 × 76 mmHg, Glasgow 15, sem rigidez de nuca, sem déficit focal, fundoscopia sem papiledema. Exames: CD4 62 células/mm³, carga viral 210.000 cópias/mL, radiografia de tórax normal; TC de crânio sem contraste, feita na triagem, sem lesões. O teste rápido de antígeno criptocócico (CrAg) por fluxo lateral no soro, pedido pela rotina do serviço, foi reagente, com título de 1:320. Ainda não iniciou TARV nem antifúngico. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

foi reagente, com título de 1:320

Resolução. A ausência de cefaleia e de sinais meníngeos convida a tratar o achado como colonização ou a apenas acompanhar, e o hábito de somar imagem antes de puncionar puxa para a RM. O CrAg sérico precede a meningite criptocócica em semanas, e uma parcela relevante dos assintomáticos já tem meningite subclínica, sobretudo com título alto (1:160 ou mais). O que define o tratamento é o líquor: com CrAg ou cultura positivos no líquor, trata-se meningite (indução com anfotericina e flucitosina, TARV adiada por 4 a 6 semanas); com líquor negativo, faz-se fluconazol preemptivo em dose alta (800 mg/dia por 2 semanas, depois 400 mg/dia por 8 semanas e manutenção) e a TARV começa em cerca de 2 semanas. Sem déficit focal, rebaixamento ou papiledema, e com TC já sem lesões, a RM não acrescenta nada que mude a conduta e só atrasa a punção. Repetir o CrAg só atrasa a decisão, e hemocultura negativa não exclui doença meníngea.

A) Repetir o CrAg sérico em 2 semanas

Errada. Repetir o teste não muda nada: o antígeno reagente já indica doença criptocócica em evolução, e o que falta saber é se há acometimento meníngeo.

B) RM de encéfalo com gadolínio ARMADILHA

Errada. É a armadilha: a RM seria o exame para déficit focal ou suspeita de criptococomas e pseudocistos; aqui não há sinal focal, a TC já afastou lesão com efeito de massa, e o que decide o antifúngico é o líquor.

C) Punção lombar com pressão de abertura CORRETA

Correta. CrAg sérico reagente com título alto e CD4 abaixo de 100 pedem punção lombar, com pressão de abertura, para separar meningite (indução) de antigenemia isolada (fluconazol preemptivo).

D) Hemocultura para fungos

Errada. Hemocultura pode confirmar fungemia, mas negativa não exclui meningite, e o tratamento depende do líquor.

Para levar. CrAg sérico reagente na pessoa com HIV e CD4 abaixo de 100, mesmo assintomática, pede punção lombar antes de escolher entre fluconazol preemptivo e tratamento de meningite.

WHO Guidelines for diagnosing, preventing and managing cryptococcal disease among adults, adolescents and children living with HIV (2022); NIH/CDC/IDSA Guidelines for Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV (Cryptococcosis); PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (MS).

37 Gastroenterologia · Impactação alimentar em jovem atópico com endoscopia de aspecto normal: biópsias esofágicas escalonadas antes de pHmetria ou manometria

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 24 anos, com rinite alérgica e asma leve em uso de budesonida-formoterol sob demanda, procura o ambulatório após o segundo episódio de impactação de carne no esôfago em um ano; no último, há três semanas, o bolo foi retirado por endoscopia de urgência, que descreveu "mucosa esofágica de aspecto normal, sem estenose", sem biópsias. Relata pirose ocasional e, desde então, usa omeprazol 20 mg/dia, com melhora parcial da pirose, mas segue comendo devagar e bebendo água para "empurrar" a comida. Nega emagrecimento, odinofagia e uso de anti-inflamatórios. Exame físico normal; IMC 23 kg/m². Hemograma com eosinófilos de 620/mm³. O médico assistente mantém o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

sem biópsias

Resolução. A pirose verdadeira e a resposta parcial ao omeprazol sustentam o rótulo de refluxo, e quem compra o rótulo pede pHmetria para documentá-lo. Mas impactação alimentar recorrente em homem jovem e atópico é esofagite eosinofílica até prova em contrário, e em 10 a 30% dos casos a mucosa parece normal à endoscopia. A endoscopia de urgência foi feita sem biópsias, e é esse o buraco do caso: o diagnóstico exige pelo menos 15 eosinófilos por campo de grande aumento, em pelo menos seis fragmentos de dois níveis do esôfago (proximal e distal). O IBP em curso não impede o exame, mas pode reduzir a contagem; o relevante é documentar a doença. Manometria e esofagograma investigam motilidade e estenose, degraus seguintes que só se justificam com biópsias normais. A eosinofilia periférica é comum na doença, mas não é critério.

A) Endoscopia com biópsias de esôfago proximal e distal CORRETA

Correta. Impactação recorrente em atópico com endoscopia prévia sem biópsias: o diagnóstico de esofagite eosinofílica depende de biópsias escalonadas, mesmo com mucosa normal.

B) Esofagograma baritado com pastilha de bário

Errada. Útil para estenose complexa ou anel antes de dilatar, mas não define esofagite eosinofílica e a endoscopia já não mostrou estenose.

C) Manometria esofágica de alta resolução

Errada. Investiga acalasia e espasmo, disfagia que costuma ser também para líquidos; vem depois de biópsias negativas.

D) pHmetria esofágica de 24 horas sem omeprazol ARMADILHA

Errada. Seria o exame da pirose refratária com endoscopia e biópsias normais; aqui a disfagia com impactação é a queixa dominante e ainda não houve biópsia.

Para levar. Impactação alimentar em jovem atópico: biópsias de esôfago proximal e distal (seis ou mais fragmentos), mesmo com mucosa normal; 15 ou mais eosinófilos por campo fecham o diagnóstico.

ACG Clinical Guideline: Eosinophilic Esophagitis (2025); AGA/JTF Guidelines for the Management of Eosinophilic Esophagitis (2020); consenso AGREE (2018)

38 Nefrologia · Proteinúria com dor neuropática e hipoidrose no homem jovem rotulado de fibromialgia · atividade da alfa-galactosidase A antes da biópsia

Dado omitido **Gabarito B**

Homem de 32 anos é encaminhado por proteinúria de 1,1 g/24 h e creatinina de 1,4 mg/dL. Desde a adolescência tem crises de dor em queimação nas mãos e nos pés, desencadeadas por febre e exercício, e quase não transpira; foi rotulado como fibromialgia aos 25 anos. Há 1 ano teve episódio de vertigem súbita, com RM mostrando lesões isquêmicas na substância branca e na circulação posterior. Ecocardiograma com hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo; PA 124/78 mmHg, sem história de hipertensão. FAN 1:160 padrão pontilhado fino, C3 e C4 normais, EAS com proteinúria e sem hematúria. O oftalmologista descreve opacidades corneanas em redemoinho; ele não usa amiodarona nem cloroquina. O exame mais adequado neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

opacidades corneanas em redemoinho

Resolução. Proteinúria com dor neuropática acral desde a adolescência, hipoidrose, AVC em jovem e hipertrofia ventricular sem hipertensão formam o quadro da doença de Fabry, e a córnea verticilada sem amiodarona ou cloroquina amarra o diagnóstico. A banca omite de propósito os angioqueratomas e a história familiar, e coloca dois distratores verdadeiros: o rótulo de fibromialgia e um FAN de 1:160, que leva o apressado à investigação de lúpus. O reflexo de quem tem proteinúria inexplicada é a biópsia renal, que mostraria inclusões lamelares nos podócitos, mas o diagnóstico no homem se faz de forma não invasiva e mais simples pela atividade da alfa-galactosidase A em leucócitos ou em gota de sangue seco, confirmada pelo gene GLA. Na mulher heterozigota a atividade pode ser normal e o teste genético é o primeiro. O diagnóstico importa porque há terapia de reposição enzimática ou chaperona, e a família deve ser rastreada.

A) Anti-DNA nativo e anti-Sm
Errada. Seria o passo com FAN positivo e sinais de lúpus (hematúria dismórfica, complemento baixo, citopenias); aqui o FAN em título baixo é ruído e o complemento é normal.

B) Atividade da alfa-galactosidase A CORRETA
Correta. No homem com quadro sugestivo (córnea verticilada sem droga que a explique), a dosagem da enzima confirma o diagnóstico sem procedimento invasivo.

C) Biópsia renal percutânea ARMADILHA
Errada. É o passo seguinte de quem não reconhece a doença sistêmica; a biópsia mostraria corpos zebrados, mas é invasiva e desnecessária para o diagnóstico no homem.

D) Eletroneuromiografia dos membros
Errada. A neuropatia da Fabry é de fibras finas, e a eletroneuromiografia costuma ser normal; não define nada.

Para levar. Doença de Fabry no homem: dor acral em queimação, hipoidrose, proteinúria, HVE e AVC precoce; o diagnóstico é a atividade da alfa-galactosidase A (na mulher, o gene GLA).

Ortiz A et al. Fabry disease revisited: management and treatment recommendations for adult patients. Mol Genet Metab 2018; KDIGO Controversies Conference on Fabry disease (2017); UpToDate 2026.

39 Hematologia · Sangramento após alteplase no TEP de alto risco: fibrinogênio abaixo de 150 pede crioprecipitado, não plasma

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 59 anos, com tromboembolismo pulmonar de alto risco (choque à admissão), recebeu alteplase 100 mg em 2 horas; a heparina não fracionada foi suspensa ao iniciar a infusão, há 3 horas. Cinquenta minutos após o término, surge sangramento ativo e volumoso no local da punção arterial femoral feita para gasometria, que não cede à compressão, e hematúria macroscópica. PA 104/66 mmHg, FC 108 bpm, SpO2 94% com cateter nasal. Exames: Hb 9,8 g/dL (12,1 g/dL à admissão), plaquetas 188.000/mm³, INR 1,4, TTPa relação 1,6, fibrinogênio 92 mg/dL (VR 200 a 400). A infusão já terminou e a compressão local continua. Além do antifibrinolítico, a medida hemostática mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

fibrinogênio 92 mg/dL (VR 200 a 400)

Resolução. O INR e o TTPa alterados puxam para o plasma, que repõe vários fatores ao mesmo tempo. Mas o que a alteplase faz é gerar plasmina, que consome o fibrinogênio, e o número que decide é ele: 92 mg/dL, muito abaixo do limiar de 150 mg/dL usado no sangramento após trombolítico. O crioprecipitado concentra fibrinogênio, fator VIII e fator XIII num volume pequeno, e é a reposição recomendada (cerca de 10 unidades, repetindo se o fibrinogênio seguir abaixo de 150), junto com ácido tranexâmico. Para elevar o fibrinogênio na mesma medida com plasma seriam necessários vários litros, o que agrava a sobrecarga numa paciente com o ventrículo direito em sofrimento. A protamina só ajudaria se houvesse heparina circulante, e a infusão foi suspensa há 3 horas; as plaquetas estão normais.

A) Concentrado de plaquetas por aférese
Errada. Plaquetas de 188.000/mm³ não justificam transfusão; seria indicada se o paciente usasse antiagregante e tivesse sangramento intracraniano, ou com plaquetopenia.

B) Sulfato de protamina endovenoso
Errada. Seria útil se a heparina não fracionada estivesse em curso ou tivesse sido suspensa há menos de 2 horas; foi suspensa há 3 horas, e o TTPa alongado reflete a fibrinólise.

C) Crioprecipitado 10 unidades CORRETA
Correta. Fibrinogênio de 92 mg/dL após trombolítico, com sangramento ativo: crioprecipitado, com nova dosagem e repetição se ficar abaixo de 150 mg/dL.

D) Plasma fresco congelado 15 mL/kg ARMADILHA
Errada, é a armadilha. O plasma é a escolha na deficiência de múltiplos fatores, como na hepatopatia ou na reversão de varfarina sem complexo protrombínico; aqui a deficiência dominante é de fibrinogênio, que o plasma repõe pouco por volume.

Para levar. Sangramento após alteplase é, antes de tudo, hipofibrinogenemia: dosar o fibrinogênio e repor com crioprecipitado (limiar de 150 mg/dL), associado a antifibrinolítico.

AHA/ASA Scientific Statement 2017 (Yaghi et al.): manejo do sangramento após alteplase; ESC 2019 Acute Pulmonary Embolism; BSH 2018 Guidelines on the use of fresh frozen plasma and cryoprecipitate (atualização 2023).

40

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Neurologia · Dissecção da carótida interna com Horner parcial em migranosa jovem: angiotomografia cervical antes de procurar forame oval

Mulher de 36 anos, com migrânea com aura visual desde a adolescência (duas crises por ano, sem profilaxia), procura o pronto-socorro por dor contínua na região cervical esquerda e na hemiface esquerda há 4 dias, diferente das crises habituais, iniciada após uma aula de ioga com extensão cervical prolongada. Hoje teve dois episódios de 10 minutos de fraqueza e dormência na mão direita com dificuldade para encontrar palavras, com recuperação completa. Não fuma e usa anticoncepcional combinado. PA 128/78 mmHg, FC 76 bpm, ritmo regular. Exame neurológico atual sem déficit motor ou de linguagem; pupila esquerda de 2 mm e direita de 4 mm, com ptose discreta à esquerda e sudorese facial preservada. TC de crânio sem contraste normal. ECG em ritmo sinusal. O exame a ser solicitado a seguir, com maior impacto na conduta, é:

O DADO QUE DECIDE

pupila esquerda de 2 mm e direita de 4 mm, com ptose discreta à esquerda

Resolução. Dois rótulos verdadeiros puxam para longe da artéria: a migrânea com aura (que associa AVC no jovem a forame oval patente e faz pensar em ecocardiograma com microbolhas) e o anticoncepcional (que puxa para trombofilia). Mas a paciente tem dor cervicofacial nova e contínua depois de hiperextensão do pescoço, AIT no hemisfério esquerdo (mão direita e linguagem) e síndrome de Horner parcial à esquerda, com sudorese preservada, o que localiza a lesão simpática pós-ganglionar, ao longo da carótida interna. Dor cervical mais Horner ipsilateral mais isquemia no mesmo território é dissecção da carótida interna até prova em contrário. O exame que muda a conduta é a imagem do vaso (angiotomografia ou angiorressonância cervical com cortes axiais em T1 com saturação de gordura), que mostra o hematoma mural e a estenose e indica antitrombótico já. Ecocardiograma e trombofilias só entram se a imagem vascular for normal.

A) Angiotomografia cervical e intracraniana CORRETA

Correta. Horner pós-ganglionar com dor cervical e AIT carotídeo do mesmo lado pede imagem do vaso cervical para confirmar dissecção e iniciar antitrombótico.

B) Ecocardiograma transtorácico com microbolhas ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria o exame num AVC criptogênico do jovem com investigação vascular normal; aqui a dor cervical e o Horner apontam para a carótida antes do coração.

C) Eletroencefalograma de rotina

Errada. Seria pensado se os episódios fossem marcha de sintomas positivos sugestivos de crise focal ou aura; fraqueza com afasia de 10 minutos é déficit negativo, isquêmico.

D) Pesquisa de trombofilias hereditárias

Errada. Trombofilia hereditária quase nunca causa evento arterial e só se investiga, em casos selecionados, depois da imagem vascular e cardíaca normais.

Para levar. Dor cervical ou facial nova com Horner (sudorese preservada) e isquemia no território da mesma carótida é dissecção: angiotomografia ou angiorressonância cervical antes de procurar forame oval.

ESO Guideline on cervical artery dissection (Debette et al., 2021); AHA/ASA Secondary Stroke Prevention Guideline 2021.

41

Negativo no meio

Gabarito C

Cardiologia · Padrão de Wellens sem dor e com troponina normal: estratégia invasiva, e não teste de esforço

Homem de 56 anos, tabagista e dislipidêmico, procura o pronto-socorro às 9 h porque, nos últimos 3 dias, teve três episódios de dor retroesternal em aperto ao caminhar rápido, com 10 a 15 minutos de duração e alívio com repouso; o último foi às 6 h. No momento, está sem dor. Exame: PA 134×82 mmHg, FC 74 bpm, ausculta cardíaca e pulmonar normais. ECG atual: ritmo sinusal, sem supradesnivelamento do segmento ST, com ondas T negativas, profundas e simétricas de V2 a V4 e ondas R preservadas nas precordiais; ECG de 1 ano atrás sem essas alterações. Troponina ultrassensível na chegada e após 2 horas: 5 e 6 ng/L (referência até 14). A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

ondas T negativas, profundas e simétricas de V2 a V4 e ondas R preservadas nas precordiais

Resolução. Sem dor e com duas troponinas normais, o caso parece angina instável de baixo risco, e a mão vai para um teste funcional, que é a armadilha. O dado que decide está no ECG: ondas T negativas, profundas e simétricas de V2 a V4, novas, com ondas R preservadas e sem supra, num paciente que acabou de ter dor, é o padrão de Wellens (tipo B), marcador de estenose crítica da descendente anterior proximal. O padrão aparece justamente no período sem dor e não depende de troponina elevada. A conduta é estratégia invasiva precoce, com cateterismo em até 24 horas, porque o risco de infarto anterior extenso nos dias seguintes é alto. Teste de esforço é contraindicado, pois pode precipitar a oclusão, e exames anatômicos não invasivos apenas atrasam a coronariografia que será feita de qualquer maneira.

A) Angiotomografia de coronárias
Errada. A angiotomografia serve para baixa a intermediária probabilidade sem marcador de alto risco; aqui o ECG já indica lesão crítica e a coronariografia será necessária de qualquer forma.

B) Teste ergométrico após 12 horas sem dor ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria a escolha na dor torácica de baixo risco com ECG normal e troponinas negativas; no padrão de Wellens o esforço pode precipitar a oclusão da descendente anterior.

C) Cineangiocoronariografia em até 24 horas CORRETA
Correta. Ondas T profundas e simétricas de V2 a V4, novas, depois de angina, é o padrão de Wellens, critério de alto risco que pede cateterismo precoce.

D) Cintilografia de perfusão miocárdica
Errada. Teste de isquemia por imagem tem o mesmo problema do teste ergométrico e posterga a anatomia num paciente de alto risco pelo ECG.

Para levar. Ondas T profundas ou bifásicas de V2 a V3 no período sem dor, com R preservada e sem supra, sugerem lesão crítica proximal da descendente anterior: cateterismo precoce, nunca teste de esforço.

Diretriz da SBC sobre Angina Instável e IAM sem Supradesnível de ST (2021); ESC 2023 (acute coronary syndromes)

42 Emergência · Intoxicação digitálica precipitada por amiodarona na DRC: a FA que regulariza sem xantopsia, com hipercalemia como rótulo

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 81 anos, com fibrilação atrial permanente, insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 35% e doença renal crônica (creatinina basal 1,8 mg/dL), é trazida por náuseas, anorexia e confusão há 4 dias. Há duas semanas o cardiologista acrescentou amiodarona por palpitações. Usa ainda furosemida, espironolactona 25 mg, sacubitril-valsartana, bisoprolol 2,5 mg e digoxina 0,25 mg/dia. PA 102 × 64 mmHg, FC 48 bpm. Potássio 5,9 mEq/L, creatinina 2,3 mg/dL, magnésio 1,9 mg/dL, TSH normal. ECG: ritmo regular de 48 bpm, sem ondas P visíveis, QRS estreito e infradesnivelamento côncavo do ST em V5 e V6. A causa mais provável do quadro é:

O DADO QUE DECIDE

ritmo regular de 48 bpm, sem ondas P visíveis

Resolução. A hipercalemia existe e tem causa verdadeira (espironolactona, sacubitril-valsartana, DRC), mas potássio de 5,9 não explica náuseas, anorexia e confusão, nem produz um ritmo regular lento numa FA permanente. O dado que decide está no ECG: uma fibrilação atrial permanente que ficou regular e lenta é bloqueio AV total com escape juncional, e isso, num paciente com digoxina, é intoxicação digitálica até prova em contrário. O gatilho é a amiodarona de duas semanas, que reduz a depuração da digoxina e eleva seu nível, somada à piora da função renal. A queixa visual (xantopsia) ajudaria, mas falta com frequência no idoso, e o ECG basta. A própria hipercalemia aqui é marcador de gravidade da intoxicação (inibição da Na/K ATPase). A conduta é suspender digoxina e amiodarona, dosar a digoxinemia e dar fragmentos Fab antidigoxina, indicados por bradiarritmia sintomática com hipercalemia; a digoxina não é removida por hemodiálise.

A) Hipercalemia pela espironolactona ARMADILHA
Errada. Explica o potássio, mas não os sintomas digestivos e neurológicos nem a FA regularizada; seria a resposta com ondas T apiculadas e QRS alargando, sem digoxina.

B) Intoxicação digitálica CORRETA
Correta. FA permanente que vira ritmo regular de 48 bpm, náuseas e confusão logo após amiodarona: intoxicação digitálica.

C) Bradicardia pelo betabloqueador
Errada. Bisoprolol 2,5 mg mantido há tempos desacelera a FA, mas não a regulariza nem explica náuseas e confusão.

D) Hipotireoidismo pela amiodarona
Errada. Hipotireoidismo por amiodarona leva meses e o TSH está normal.

Para levar. Paciente com digoxina cuja FA fica regular e lenta tem BAV total por intoxicação digitálica. Amiodarona eleva o nível da digoxina; o tratamento é Fab antidigoxina, não hemodiálise.

Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca SBC 2018 e atualização 2021; AHA 2023 Focused Update on Management of Patients With Cardiac Arrest or Life-Threatening Toxicity Due to Poisoning.

43 Reumatologia · Hidroxicloroquina na doença renal crônica: dose por peso real e rastreio retiniano anual desde o início

Grade X / Y **Gabarito A**

Mulher de 46 anos, com lúpus eritematoso sistêmico, peso de 50 kg e taxa de filtração glomerular estimada de 38 mL/min/1,73 m², vai iniciar hidroxicloroquina; o exame oftalmológico basal é normal. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, a dose diária máxima e a periodicidade do rastreio de retinopatia são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

taxa de filtração glomerular estimada de 38 mL/min/1,73 m²

Resolução. A dose máxima é de 5 mg/kg/dia de peso real, o que dá 250 mg para 50 kg; os 400 mg de hábito ultrapassam o limite e são o maior fator de risco modificável de retinopatia. A metade que engana é a periodicidade: o esquema de exame basal e rastreio anual só após 5 anos vale para quem não tem fator de risco maior. Doença renal crônica reduz a depuração da droga e é fator de risco maior, assim como tamoxifeno, doença retiniana prévia e dose acima de 5 mg/kg; com qualquer deles, o rastreio anual (campo visual automatizado e OCT) começa desde o início. Por isso a armadilha acerta a dose e erra a vigilância.

A) 250 mg / anual desde o início CORRETA
Correta. 5 mg/kg de peso real dá 250 mg, e a TFG de 38 é fator de risco maior, que antecipa o rastreio anual.

B) 400 mg / anual desde o início
Errada. O rastreio está certo para quem tem DRC, mas 400 mg excedem 5 mg/kg em quem pesa 50 kg.

C) 250 mg / anual após 5 anos ARMADILHA
Errada. A dose está certa, mas o rastreio anual só após 5 anos vale para quem não tem fator de risco; a DRC antecipa.

D) 400 mg / anual após 5 anos
Errada nas duas metades: dose acima de 5 mg/kg e vigilância de quem não tem fator de risco.

Para levar. Hidroxicloroquina: no máximo 5 mg/kg/dia de peso real; com DRC, tamoxifeno ou doença retiniana, rastreio anual desde o início.

American Academy of Ophthalmology, Recommendations on screening for chloroquine and hydroxychloroquine retinopathy (2016 revision); EULAR recommendations for SLE (2023).

---

44 Oncologia · Disfunção ventricular por trastuzumabe com FE abaixo de 40%: suspender temporariamente e iniciar cardioproteção

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 49 anos, com carcinoma ductal invasivo de mama HER2 positivo, estádio II, operada, recebeu doxorrubicina e ciclofosfamida (4 ciclos) e está no 5º mês de trastuzumabe adjuvante a cada 3 semanas. Ecocardiograma antes do trastuzumabe: fração de ejeção de 63%. No ecocardiograma de controle de hoje, realizado na véspera do próximo ciclo, a fração de ejeção de 37%, com hipocinesia difusa. Está assintomática, sem dispneia ou edema; PA 118 × 72 mmHg, FC 76 bpm, sem estertores, sem turgência jugular. BNP 210 pg/mL; troponina normal. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

a fração de ejeção de 37%

Resolução. A paciente está assintomática e o trastuzumabe reduz recidiva e morte no câncer HER2, então a tentação é mantê-lo com cardioproteção, que é exatamente o certo na disfunção moderada. A diretriz de cardio-oncologia separa por fração de ejeção: queda de 10 pontos ou mais para 40 a 49%, assintomática, permite manter o anti-HER2 com IECA ou BRA e betabloqueador e ecocardiogramas mais frequentes; fração abaixo de 40%, mesmo assintomática, é disfunção grave e exige interrupção temporária, tratamento de insuficiência cardíaca e decisão multidisciplinar. A cardiotoxicidade do trastuzumabe (tipo 2) costuma ser reversível, e a reintrodução é possível se a fração de ejeção se recuperar; por isso não se suspende definitivamente de saída. A antraciclina prévia aumenta o risco e explica a queda.

A) Manter o trastuzumabe sem mudanças
Errada. Seria aceitável com queda pequena e fração de ejeção preservada acima de 50%; com 37% há disfunção grave.

B) Suspender definitivamente e não reintroduzir
Errada. A cardiotoxicidade do trastuzumabe costuma ser reversível; com recuperação da fração de ejeção, a reintrodução pode ser discutida.

C) Suspender por ora, com IECA e betabloqueador CORRETA
Correta. Fração de ejeção de 37% é disfunção grave: interrupção temporária, IECA e betabloqueador, e reavaliação para possível reintrodução.

D) Manter o trastuzumabe com IECA e betabloqueador ARMADILHA
Errada. É a conduta da disfunção moderada assintomática (fração de ejeção de 40 a 49%); abaixo de 40%, o trastuzumabe precisa ser interrompido.

Para levar. Trastuzumabe e fração de ejeção: 40 a 49% assintomática, manter com cardioproteção; abaixo de 40% ou sintomática, interromper e tratar, com possível reintrodução após recuperação.

ESC Guidelines on cardio-oncology (2022); ASCO Guideline: Prevention and Monitoring of Cardiac Dysfunction in Survivors of Adult Cancers (2017)

---

45 Infectologia · Primeira recorrência de Clostridioides difficile após vancomicina: fidaxomicina, e transplante fecal só depois

Cronologia | Gabarito D

Mulher de 71 anos teve o primeiro episódio de diarreia por Clostridioides difficile há 7 semanas, após cefalosporina para pielonefrite, tratado com vancomicina oral 125 mg de 6/6 horas por 10 dias, com resolução completa em 4 dias. Há 3 dias, 12 dias após o fim da vancomicina e sem novo antibiótico, voltou a ter 6 evacuações líquidas por dia, com cólica e sem sangue. Usa omeprazol 20 mg/dia desde aquela internação. Exame: T 37,5 °C, PA 128 × 74 mmHg, abdome flácido, sem distensão. Leucócitos 12.400/mm³, creatinina 0,9 mg/dL (basal 0,8 mg/dL), albumina 3,6 g/dL. GDH e toxinas A/B positivas nas fezes. Além de reavaliar o omeprazol, o tratamento mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Há 3 dias, 12 dias após o fim da vancomicina

Resolução. Diarreia recorrente até 8 semanas após o fim do tratamento é recorrência, e esta é a primeira. Repetir o mesmo curso de vancomicina, que funcionou da primeira vez, é a resposta automática, mas a diretriz não a recomenda após recorrência de um curso padrão de vancomicina: a escolha preferida é fidaxomicina (padrão ou estendida em pulsos), com vancomicina em esquema prolongado com redução gradual e pulsos como alternativa. O episódio não é grave (leucócitos abaixo de 15.000 e creatinina abaixo de 1,5 mg/dL). O transplante de microbiota fecal é indicado a partir da segunda recorrência, depois de tratamento antibiótico adequado das recorrências; usá-lo agora pula uma etapa. Metronidazol não é recomendado para recorrência. Suspender o inibidor de bomba sem indicação reduz o risco de nova recorrência.

A) Transplante de microbiota fecal
Errada. O transplante fecal entra a partir da segunda recorrência; esta é a primeira.

B) Metronidazol oral por 14 dias
Errada. Metronidazol perdeu espaço até no primeiro episódio e não é recomendado na recorrência.

C) Vancomicina oral por 10 dias ARMADILHA
Errada. É a armadilha: após recorrência de curso padrão de vancomicina, repetir o mesmo curso não é recomendado; a vancomicina só entraria em esquema prolongado com redução gradual e pulsos.

D) Fidaxomicina oral por 10 dias CORRETA
Correta. Primeira recorrência, não grave, após vancomicina: fidaxomicina, que reduz nova recorrência.

Para levar. C. difficile: primeira recorrência, fidaxomicina (ou vancomicina em redução gradual e pulsos); transplante fecal a partir da segunda recorrência.

IDSA/SHEA Clinical Practice Guideline: Focused Update on the Management of Clostridioides difficile Infection in Adults (2021); ACG Clinical Guidelines: Prevention, Diagnosis, and Treatment of C. difficile Infections (2021).

46

Endocrinologia · Hipotireoidismo central em reposição: TSH normal não serve de alvo, ajustar pela T4 livre

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 46 anos foi operada há 8 meses de macroadenoma hipofisário não funcionante e evoluiu com hipopituitarismo. Usa hidrocortisona 15 mg/dia, levotiroxina 75 mcg/dia desde a cirurgia e, há 3 meses, estradiol oral para a deficiência gonadotrófica. Queixa-se de cansaço, constipação, intolerância ao frio e ganho de 4 kg nos últimos meses. Exame: PA 112 × 70 mmHg, FC 58 bpm, pele seca, fase de relaxamento dos reflexos lentificada. Exames: TSH 0,9 mUI/L (VR 0,4 a 4,0), T4 livre 0,62 ng/dL (VR 0,9 a 1,8), sódio 138 mEq/L, glicemia 86 mg/dL. Ressonância de sela de controle há 1 mês: sem tumor residual. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE
T4 livre 0,62 ng/dL (VR 0,9 a 1,8)

Resolução. O rótulo verdadeiro é o TSH normal, que no hipotireoidismo primário encerraria a discussão. No hipotireoidismo central a hipófise não produz TSH adequado (ou produz TSH com bioatividade reduzida), e o valor do TSH não reflete a reposição: ele pode estar normal, baixo ou até discretamente alto com o paciente hipotireoideo. O alvo da levotiroxina é a T4 livre na metade superior da faixa de referência, coletada antes da dose. Esta paciente está clinicamente hipotireoidea, com T4 livre abaixo do normal, e acabou de iniciar

estradiol oral, que aumenta a TBG e a necessidade de levotiroxina. A conduta é aumentar a dose e reavaliar pela T4 livre em 6 a 8 semanas. O cortisol já está reposto (a regra de repor glicocorticoide antes da levotiroxina está cumprida), de modo que não há o risco de precipitar crise adrenal nem motivo para retestar o eixo.

A) Manter a dose, pois o TSH está normal ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o TSH só serve de alvo quando a hipófise está íntegra; no hipotireoidismo central ele é inútil para titular a dose.

B) Reduzir a hidrocortisona para 10 mg/dia
Errada. Hidrocortisona 15 mg/dia é dose fisiológica; reduzir o glicocorticoide não trata cansaço com T4 livre baixa e arrisca insuficiência adrenal.

C) Teste com ACTH antes de ajustar
Errada. O teste de estímulo avalia a reserva adrenal de quem ainda não recebe glicocorticoide; ela já usa hidrocortisona em dose de reposição, e o teste sob reposição não tem leitura nem muda a conduta tireoidiana.

D) Aumentar a levotiroxina pela T4 livre CORRETA
Correta. T4 livre de 0,62 com sintomas e estradiol oral recente: aumentar a levotiroxina e titular pela T4 livre, mirando a metade superior da faixa.

Para levar. No hipotireoidismo central, titule a levotiroxina pela T4 livre (metade superior da faixa), nunca pelo TSH; estrogênio oral aumenta a dose necessária.

Endocrine Society 2016 (Hormonal replacement in hypopituitarism in adults); ETA 2018 (Guidelines on the diagnosis and management of central hypothyroidism).

47

Hematologia · Hemofilia A com inibidor em profilaxia com emicizumabe: sangramento agudo trata-se com fator VII ativado, não com complexo protrombínico ativado

Droga a deduzir | Gabarito D

Homem de 24 anos, com hemofilia A grave e inibidor de alto título (último título de 14 UB/mL), sem resposta à imunotolerância feita na infância. Há 1 ano está em profilaxia com injeção subcutânea semanal de um anticorpo monoclonal biespecífico, com queda importante dos sangramentos. Hoje, após cair de bicicleta, apresenta hemartrose do joelho direito, com dor intensa, joelho tenso e quente e flexão limitada. PA 128/76 mmHg, FC 96 bpm. Exames: Hb 13,4 g/dL, plaquetas 244.000/mm³, TTPa 29 segundos (VR 25 a 35). O agente hemostático mais adequado para este episódio é:

O DADO QUE DECIDE
injeção subcutânea semanal de um anticorpo monoclonal biespecífico

Resolução. Na hemofilia com inibidor de alto título, os agentes de bypass são o fator VII ativado recombinante e o complexo protrombínico parcialmente ativado, e o apressado escolhe o segundo por ser o que se lembra primeiro. A droga a deduzir muda tudo: anticorpo biespecífico subcutâneo semanal na hemofilia A é o emicizumabe, que liga fator IXa e fator X e imita o fator VIII. No estudo HAVEN 1, o complexo protrombínico ativado em dose acima de 100 U/kg/dia por mais de 24 horas, somado ao emicizumabe, causou microangiopatia trombótica e trombose; por isso o fator VII ativado recombinante é o agente de primeira escolha nos sangramentos de quem usa emicizumabe. O TTPa normal não indica hemostasia

corrigida: o emicizumabe normaliza o TTPa artificialmente, e o exame não serve para monitorar. Fator VIII em dose alta é neutralizado por inibidor de 14 UB/mL.

A) Concentrado de fator VIII em dose alta
Errada. Fator VIII em dose alta só funciona com inibidor de baixo título (abaixo de 5 UB/mL); com 14 UB/mL é neutralizado.

B) Complexo protrombínico parcialmente ativado ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria um agente de bypass válido sem emicizumabe; com ele, há risco de microangiopatia trombótica e trombose.

C) Plasma fresco congelado
Errada. O plasma não tem fator suficiente para vencer o inibidor e não é tratamento de hemofilia com concentrados disponíveis.

D) Fator VII ativado recombinante CORRETA
Correta. Em usuário de emicizumabe com inibidor, o sangramento agudo se trata com fator VII ativado recombinante.

Para levar. Hemofilia com inibidor em emicizumabe: sangramento agudo com fator VII ativado recombinante; evitar complexo protrombínico ativado (microangiopatia trombótica), e o TTPa normal não tranquiliza.

WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition (2020); Oldenburg et al., HAVEN 1, NEJM 2017; MS Manual de Hemofilia 2015 e Nota Técnica do emicizumabe (2021).

48

Nefrologia · Nefropatia por IgA com poucas crescentes, proteinúria abaixo de 0,5 g/dia e função estável · seguimento, e não imunossupressão

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 29 anos tem hematúria microscópica descoberta em exame admissional. Nunca teve hematúria macroscópica. Sem edema, sem lesões cutâneas, sem artralgia ou dor abdominal. PA 122/76 mmHg em três consultas, com MAPA normal. Creatinina de 1,0 mg/dL (TFGe de 98 mL/min/1,73 m²), estável em três dosagens nos últimos 4 meses; proteinúria de 0,3 g/24 h, confirmada em nova coleta; C3 e C4 normais; FAN, ANCA e sorologias para hepatites B e C e HIV negativos. Não usa medicações. A biópsia renal mostra proliferação mesangial com depósitos dominantes de IgA na imunofluorescência, hipercelularidade endocapilar em alguns glomérulos e crescentes celulares em 2 de 24 glomérulos, com fibrose intersticial inferior a 10%. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE
proteinúria de 0,3 g/24 h, confirmada em nova coleta

Resolução. A palavra crescentes na biópsia é o rótulo verdadeiro que puxa para pulsoterapia e ciclofosfamida, a conduta da glomerulonefrite rapidamente progressiva. Mas crescentes em menos de 10% dos glomérulos, com creatinina estável em três dosagens, não configuram forma rapidamente progressiva, e a KDIGO diz que a presença de crescentes, sozinha, não indica imunossupressão, nem o escore MEST-C serve para decidir o tratamento. O que define o paciente em risco de progressão, e portanto candidato a terapia dirigida ao processo imune (budesonida de liberação entérica ou corticoide sistêmico em dose reduzida), é a proteinúria igual ou acima de 0,5 g/dia; aqui ela é de 0,3 g, confirmada, com PA e filtração

normais. A conduta é seguimento de PA, proteinúria e creatinina a cada poucos meses, com orientação de estilo de vida. Se a proteinúria passar de 0,5 g/dia ou a PA subir, entram o bloqueio do SRAA em dose máxima e o iSGLT2 e, conforme o risco, a terapia imune.

A) Pulsoterapia e ciclofosfamida ARMADILHA
Errada. Seria a conduta na nefropatia por IgA crescêntica com queda rápida da filtração (crescentes em grande parte dos glomérulos e creatinina subindo em semanas); aqui a função está estável.

B) Budesonida de liberação entérica
Errada. A budesonida entérica entra no paciente em risco de progressão, com proteinúria igual ou acima de 0,5 g/dia apesar do suporte; com 0,3 g/dia não há indicação.

C) Seguimento clínico e laboratorial CORRETA
Correta. Proteinúria de 0,3 g/dia, PA normal e função estável: as crescentes isoladas não indicam imunossupressão, e a conduta é seguir PA, proteinúria e creatinina.

D) Prednisona em dose reduzida
Errada. Corticoide em dose reduzida é opção para quem tem proteinúria persistente igual ou acima de 0,5 g/dia; não se usa pelo achado de crescentes isoladas.

Para levar. Na nefropatia por IgA, crescente isolada com função estável não indica imunossupressão. A proteinúria (0,5 g/dia ou mais) define o risco e a terapia; abaixo disso, com PA normal, seguimento.

KDIGO 2025 Clinical Practice Guideline for the Management of IgA Nephropathy and IgA Vasculitis; KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases.

---

49 Oncologia · Febre em paciente com metástases hepáticas e cateter implantado: febre neoplásica após investigação negativa

Rótulo verdadeiro | Gabarito B

Homem de 63 anos, com adenocarcinoma de cólon e múltiplas metástases hepáticas, portador de cateter venoso totalmente implantado, está em pausa de quimioterapia há 5 semanas. Há 3 semanas tem febre diária de até 38,6 °C, no fim da tarde, com sudorese, sem calafrios, e mantém-se bem entre os picos. Recebeu ceftriaxona por 7 dias e, depois, piperacilina-tazobactam por 5 dias, sem nenhuma mudança na curva térmica. Exame: FC 92 bpm, PA 126 × 80 mmHg, sítio do cateter sem hiperemia ou secreção, sem sopros, hepatomegalia nodular indolor. Exames: leucócitos 9.100/mm³ com neutrófilos de 6.300/mm³, PCR 9,2 mg/dL, procalcitonina 0,08 ng/mL, três pares de hemoculturas pareadas do cateter e periféricas negativas, urocultura negativa. TC de tórax e abdome: metástases hepáticas maiores que no exame anterior, sem coleções, abscessos ou trombose. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE
três pares de hemoculturas pareadas do cateter e periféricas negativas

Resolução. Cateter implantado em paciente oncológico com febre é rótulo verdadeiro de infecção relacionada ao cateter, e o reflexo é retirar o dispositivo ou escalonar antibiótico. Mas a investigação foi completa e negativa: três pares de hemoculturas pareadas sem crescimento, procalcitonina baixa, sítio limpo, TC sem coleção, e nenhuma resposta a dois esquemas de largo espectro. Febre vespertina com bom estado entre os picos, em doença hepática metastática em progressão, é febre neoplásica, diagnóstico de exclusão mediado por citocinas tumorais. Não há neutropenia (neutrófilos de 6.300) nem quimioterapia recente. O

teste do naproxeno (250 a 375 mg de 12 em 12 horas por 3 dias) costuma suprimir a febre neoplásica e apoia o diagnóstico; os antibióticos podem ser suspensos.

A) Neutropenia febril
Errada. Exige neutrófilos abaixo de 500 ou em queda para isso; aqui são 6.300 e não há quimioterapia há 5 semanas.

B) Febre neoplásica CORRETA
Correta. Febre vespertina com bom estado, investigação infecciosa negativa e falha de dois esquemas em doença metastática hepática em progressão.

C) Abscesso hepático piogênico
Errada. Daria coleção na TC e, em geral, procalcitonina alta e hemocultura positiva; a TC mostra só metástases.

D) Infecção do cateter implantado ARMADILHA
Errada. Seria a primeira hipótese com hemocultura do cateter positiva ou crescendo antes da periférica; aqui as três pareadas foram negativas e o sítio está limpo.

Para levar. Febre neoplásica é diagnóstico de exclusão: culturas e imagem negativas, falha de antibiótico e bom estado entre os picos; o naproxeno costuma suprimi-la.

IDSA Clinical Practice Guideline for Catheter-Related Bloodstream Infection (2009); Zell JA, Chang JC. Neoplastic fever: a neglected paraneoplastic syndrome. Support Care Cancer (2005); NCCN Guideline Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections (2025)

50

Neurologia · Psicose na doença de Parkinson avançada: amantadina sem ajuste à função renal, com bacteriúria assintomática como rótulo

Rótulo verdadeiro | **Gabarito D**

Mulher de 74 anos, com doença de Parkinson há 9 anos, usa levodopa/benserazida 200/50 mg 4 vezes ao dia, dose estável há 2 anos. Por discinesias de pico de dose, o neurologista acrescentou amantadina 100 mg de 12/12 horas há 3 semanas, com boa resposta. Há 5 dias passou a ver 'crianças e bichos' no quarto à noite, com crítica parcial, e fica confusa à tarde; está mais sonolenta e surgiu livedo reticular nas pernas. Tem também diabetes tipo 2 e doença renal crônica (creatinina 2,1 mg/dL, TFGe 23 mL/min/1,73 m²). Tax 36,7 °C, PA 128/70 mmHg. Urina: leucócitos 25 por campo, nitrito positivo; urocultura com mais de 100.000 UFC/mL de E. coli; sem disúria, sem febre. Sódio 138 mEq/L, glicemia 142 mg/dL. A causa mais provável do quadro atual é:

O DADO QUE DECIDE
TFGe 23 mL/min/1,73 m²

Resolução. A urocultura positiva é verdadeira e oferece a explicação de manual para delirium no idoso. Mas não há febre, disúria nem leucocitose descrita: é bacteriúria assintomática, comum na diabética idosa, e não explica sozinha alucinações visuais com livedo reticular. A amantadina é excretada quase inteiramente pelo rim; com TFGe de 23 a dose deveria ser 100 mg em dias alternados ou menos, e ela recebe 200 mg/dia há 3 semanas. O acúmulo produz alucinações visuais, confusão, sonolência e mioclonias, e o livedo reticular é efeito próprio da droga. A levodopa está estável há 2 anos, e a demência da doença de Parkinson não começa em 5 dias logo após uma droga nova. A conduta é reduzir ou suspender a amantadina (retirada gradual) antes de pensar em antipsicótico, e não tratar a bacteriúria.

A) Infecção do trato urinário ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria a causa com febre, disúria ou sinais sistêmicos; sem eles, urocultura positiva na idosa diabética é bacteriúria assintomática e não se trata.

B) Demência da doença de Parkinson

Errada. Alucinações visuais e flutuação aparecem na demência da doença de Parkinson avançada, mas ela se instala em meses, não em 5 dias, 3 semanas depois de droga nova e com livedo; isso aponta para toxicidade.

C) Excesso de levodopa

Errada. Seria considerada se a dose de levodopa tivesse subido; está estável há 2 anos, e o que mudou foi a amantadina.

D) Acúmulo de amantadina CORRETA

Correta. Amantadina em dose plena com TFGe de 23 acumula e causa alucinações, confusão e livedo reticular; ajusta-se pela função renal.

Para levar. Psicose na doença de Parkinson: procure primeiro a droga nova e a dose ajustada ao rim (amantadina, anticolinérgico, agonista) antes do antipsicótico; bacteriúria sem sintomas não explica delirium.

MDS Evidence-Based Medicine Review on treatments for motor symptoms of PD 2018; bula ANVISA da amantadina (ajuste renal); IDSA Asymptomatic Bacteriuria Guideline 2019.